

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENCEGAH STUNTING

Tintin Sumarni, S.Kp., M.Kep.

Dr. Gusnedi, Mph.

Deharnita, S.Kep., M.Kes.

Dr. Ns. Aini Yusra, M.Kep., Sp.Kep.Mb.

R Firwandi Marza, M.Kes.

Abd Gafar, S.Kep., Mph





PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENCEGAH STUNTING

Penulis:

Tintin Sumarni, S.Kp., M.Kep.

Dr. Gusnedi, Mph.

Deharnita, S.Kep., M.Kes.

Dr. Ns. Aini Yusra, M.Kep., Sp.Kep.Mb.

R Firwandi Marza, M.Kes.

Abd Gafar, S.Kep., Mph.



Optimal
Untuk
Negeri



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENCEGAH STUNTING

Penulis: Tintin Sumarni, S.Kp., M.Kep.

Dr. Gusnedi, Mph.

Deharnita, S.Kep., M.Kes.

Dr. Ns. Aini Yusra, M.Kep., Sp.Kep.Mb.

R Firwandi Marza, M.Kes.

Abd Gafar, S.Kep., Mph.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-95-1

Terbit: September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



Instagram: @bimbel.optimal

Tiktok: @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku "Pemberdayaan Masyarakat Mencegah Stunting" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan referensi Pengabmas bagi mahasiswa keperawatan serta masyarakat di Indonesia dalam memahami-dan-menerapkan pemberdayaan, pencegahan dan menanggulangi stunting di Indonesia.

Buku ini terdiri dari beberapa pokok-bahasan penting yang mencakup-konsep dasar seperti indikator penilaian, ciri-ciri, factor yang mempengaruhi, penyebab, dampak stunting. Selanjutnya, pembaca akan diajak mendalami cara pencegahan dan penanggulangan stunting dari beberapa sasaran mulai dari remaja, ibu hamil, ibu balita sampai kader.

Buku ini membahas stunting sebagai salah satu permasalahan gizi kronis yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menyebabkan anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini bukan hanya masalah pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, serta kualitas hidup anak di masa depan.

Dalam buku ini dijelaskan secara komprehensif faktor-faktor penyebab stunting. Faktor langsung meliputi asupan gizi yang tidak memadai, praktik pemberian ASI yang kurang optimal, serta penyakit infeksi yang berulang. Sementara itu, faktor tidak langsung mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, sanitasi lingkungan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan pemahaman yang menyeluruh, diharapkan pembaca dapat melihat stunting sebagai masalah multidimensi.

Buku ini juga menyoroti kelompok rentan yang memiliki peran penting dalam pencegahan stunting, yaitu remaja putri dan ibu hamil. Remaja putri yang mengalami anemia atau gizi kurang berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah di kemudian hari. Ibu hamil dengan status gizi yang buruk berpotensi besar melahirkan anak yang tumbuh tidak optimal. Oleh karena itu, perbaikan gizi sejak remaja hingga masa kehamilan menjadi kunci penting pencegahan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, masyarakat dan semua pihak yang berkecimpung dalam mencegah dan menanggulangi stunting. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan-buku ini. Kritik-dan-saran yang membangun sangat kami-harapkan demi perbaikan edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu dan praktik keperawatan di Indonesia.

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

BAB 2 KONSEP STUNTING.....	3
A. Definisi Stunting.....	3
B. Ciri-Ciri Anak Stunting	4
C. Faktor yang Mempengaruhi Stunting	5
D. Penyebab Stunting dilihat dari Segi Remaja Putri dan Ibu Hamil.....	10
E. Dampak Stunting.....	12
F. Indikator Penentuan Stunting	13
G. Penilaian Status Gizi.....	15
H. Titik Kritis Periode Emas	16
I. Rangkuman Materi.....	18

BAB 3 PENCEGAHAN STUNTING SECARA UMUM	21
A. Pencegahan Stunting	21
B. Program Utama Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting	22
C. Rangkuman Materi.....	23
D. Glosarium.....	23

BAB 4 PENCEGAHAN STUNTING SASARAN KADER KESEHATAN	25
A. Sebagai Penyuluh	25
B. Sebagai Pencatatan.....	29
C. Sebagai Penggerak	30
D. Rangkuman Materi.....	34
E. Glosarium.....	35

BAB 5 PENCEGAHAN STUNTING SASARAN REMAJA PUTRI	37
---	-----------

A. Skrining Anemia Melalui Pemeriksaan HB.....	37
B. Konsumsi tablet tambah darah (TTD).....	38
C. Edukasi Gizi Seimbang.....	38
D. Kebersihan dan kesehatan yang penting dijaga bagi remaja	41
E. Olah raga dan rekreasi.....	42
F. Prakonsepsi.....	42
G. Rangkuman Materi.....	47
H. Glosarium.....	48
 BAB 6 PENCEGAHAN STUNTING SASARAN IBU HAMIL	49
A. Pemeriksaan Kehamilan	49
B. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil.....	49
C. Rangkuman Materi.....	58
D. Glosarium.....	59
 BAB 7 PENCEGAHAN STUNTING SASARAN IBU DENGAN ANAK STUNTING	61
A. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Rutin di Posyandu.....	61
B. ASI Eksklusif pada Bayi < 6 Bulan	63
C. Hal-hal penting yang harus diperhatikan pada anak stunting	69
D. Rangkuman Materi.....	78
E. Glosarium.....	79
 BAB 8 IMPLEMENTASI KOTA SOLOK DALAM PENANGANAN STUNTING.	81
A. Pembentukan dan Penguatan Tim	81
B. Program Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif:	81
C. Inovasi dan Edukasi.....	82
D. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor.....	82
E. Rangkuman Materi.....	82
F. Glosarium.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	85
PROFIL PENULIS	87





BAB 1

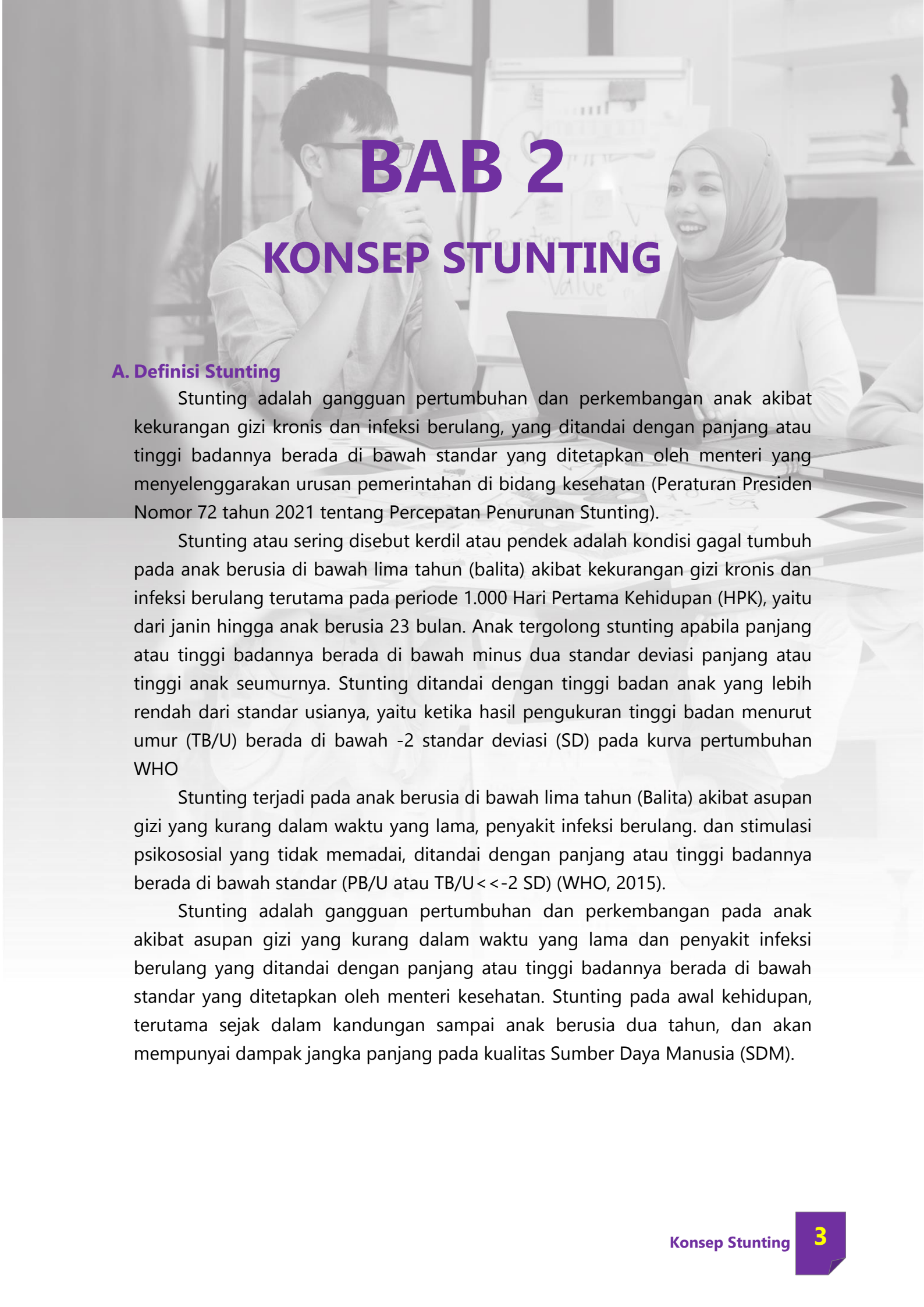
PENDAHULUAN

Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba, pada umumnya dimulai dari weight faltering (gagal tumbuh), jika berlanjut tanpa intervensi yang optimal akan menyebabkan terjadinya gizi kurang dan gizi buruk. Apabila kekurangan gizi ini berlangsung kronis/lama maka perlambatan pertumbuhan linier dapat berlanjut menjadi stunting.

Menurut WHO (World Health Organization) menunjukkan angka kejadian stunting di Asia Tenggara tahun 2022 yaitu 26,4%. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8%, sedangkan di provinsi Sumatra Barat prevalensi 23,6%.

Permasalahan gizi pada ibu hamil sering terjadi karena adanya masalah pada saat remaja dan sebelum hamil. Kekurangan gizi kronis dan anemia pada remaja berdampak buruk pada kesehatan dan perkembangan mereka. Tingginya angka malnutrisi pada remaja putri, calon pengantin dan ibu hamil berkontribusi pada risiko peningkatan morbiditas dan mortalitas pada kehamilan dan persalinan, serta melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematur. Kondisi ini berkontribusi pada siklus malnutrisi antar generasi.

Pencegahan dan penanggulangannya memerlukan pemahaman yang komprehensif, terutama bagi kelompok rentan seperti remaja putri, ibu hamil, kader kesehatan, dan ibu dengan anak stunting. Modul ini dirancang untuk memberikan materi pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami menggunakan media gambar dan animasi, sehingga meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan penerapan perilaku sehat.



BAB 2

KONSEP STUNTING

A. Definisi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting).

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya, yaitu ketika hasil pengukuran tinggi badan menurut umur (TB/U) berada di bawah -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO

Stunting terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama, penyakit infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar (PB/U atau TB/U < -2 SD) (WHO, 2015).

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama dan penyakit infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. Stunting pada awal kehidupan, terutama sejak dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun, dan akan mempunyai dampak jangka panjang pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).



Gambar 2.1 Definisi Stunting

B. Ciri-Ciri Anak Stunting

Anak pendek atau stunted diidentifikasi dengan membandingkan tinggi seorang anak dengan standar tinggi anak pada populasi yang normal sesuai dengan usia dan jenis kelamin yang sama. Anak dikatakan pendek atau stunted jika tingginya berada di bawah -2 SD dari standard WHO.

Seorang anak yang pendek atau stunted belum tentu masuk dalam kategori anak stunting. Namun anak yang stunting sudah dapat dipastikan mempunyai status gizi pendek atau stunted. Anak stunting yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah tangga atau keluarga yang kurang mampu atau yang berada di bawah garis kemiskinan karena ternyata stunting juga dialami oleh rumah tangga atau keluarga yang tidak miskin atau yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan periode kritis sebagai awal terjadinya stunting yang selanjutnya akan memberikan dampak jangka panjang hingga akan berulang dalam siklus kehidupan.

Stunting pada anak menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, gangguan pada perkembangan otak, gangguan terhadap perkembangan motorik dan terhambatnya pertumbuhan mental anak. Pertumbuhan tidak optimal dalam masa janin dan atau selama periode 1000 HPK memiliki dampak jangka panjang. Bila faktor eksternal (setelah lahir) tidak mendukung, pertumbuhan stunting dapat menjadi permanen sebagai remaja pendek.

Stunting menjadi penting karena dampaknya yang serius terhadap kualitas anak bukan hanya pada ukuran tubuh yang pendek saja. Ukuran tubuh yang pendek pada usia dini terutama saat lahir menandakan telah terjadi hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada organ tubuh lainnya termasuk otak, jantung, ginjal, otot, tulang dan organ tubuh lainnya. Ciri-ciri anak mengalami stunting:

1. Anak memiliki tinggi badan yang pendek dibandingkan tinggi badan normal seusianya. Anak dikatakan pendek apabila panjang badan atau tinggi badan

anak berdasarkan usianya mempunyai nilai Z-Score kurang dari -2 dari standar deviasi.

2. Anak cenderung memiliki performa kurang baik pada fokus perhatian dan memori belajar serta memiliki penurunan dalam kemampuan kognitif dan prestasi belajar di sekolah
3. Anak mudah mengalami sakit terutama penyakit infeksi karena anak penderita stunting cenderung memiliki gangguan metabolisme dan penurunan kekebalan tubuh. Anak stunting akan lebih sulit dan lebih lama sembuh ketika sakit. Saat dewasa penderita stunting rentan mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, obesitas dan lainnya
4. Memiliki pertumbuhan gigi yang lambat akibat tidak tercukupinya kebutuhan gizi sehingga mengganggu proses tumbuh kembangnya termasuk pertumbuhan gigi.
5. Wajah tampak lebih muda dari usianya karena pengaruh gangguan pertumbuhannya.
6. Pada usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam serta tidak banyak melakukan kontak mata (eye contact) dengan orang lain.
7. Berat badan balita saat ditimbang tidak naik bahkan cenderung mengalami penurunan.
8. Perkembangan tubuh saat remaja terhambat seperti telat menarche (menstruasi pertama pada anak perempuan)
9. Penelitian menunjukkan bahwa anak stunting kemungkinan tidak akan pernah mencapai potensi penuh dan memiliki perkembangan kognitif yang rendah. Kondisi ini menyebabkan pendidikan menjadi kurang optimal, terjadi penurunan kapasitas intelektual dan perkembangan motorik anak.
10. Selain pendek dan kerdil, anak yang mengalami stunting juga terlihat kurus. Walaupun terlihat pendek dan kurus tubuh anak tetap proporsional.

Kondisi pendek atau stunted merupakan penanda yang bisa dideteksi paling dini yaitu pada saat bayi lahir dimana bayi mempunyai Panjang Badan Lahir Rendah (PBLR) yaitu kurang dari 48 cm dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu kurang dari 2500 gram dan bayi berukuran kecil untuk umur gestasinya. Sedangkan untuk kondisi kecerdasan atau kemampuan kognitifnya akan terlihat saat anak memasuki pra sekolah atau sekolah. Untuk kondisi penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, dan lainnya akan terlihat saat memasuki usia dewasa.

C. Faktor yang Mempengaruhi Stunting

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih

detail, beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian stunting dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Faktor Langsung

a. Faktor ibu

Faktor ibu dapat dikarenakan nutrisi yang buruk selama prakonsepsi, kehamilan, dan laktasi. Selain itu juga dipengaruhi perawakan ibu seperti usia ibu terlalu muda atau terlalu tua, pendek, infeksi, kehamilan muda, kesehatan jiwa, BBLR, IUGR dan persalinan prematur, jarak persalinan yang dekat dan hipertensi.

b. Faktor Genetik

Faktor genetik merupakan modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan. Melalui genetik yang berada dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. Menurut Amigo et al salah satu atau kedua orang tua yang pendek akibat kondisi patologi (seperti defisiensi hormon pertumbuhan) memiliki gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek sehingga memperbesar peluang anak mewarisi gen tersebut dan tumbuh menjadi stunting. Akan tetapi, bila orang tua pendek akibat kekurangan zat gizi atau penyakit, kemungkinan anak dapat tumbuh dengan tinggi badan normal selama anak tersebut tidak terpapar faktor resiko yang lain.

c. Asupan Makanan

Kualitas makanan yang buruk meliputi kualitas mikronutrien yang buruk, kurangnya keragaman dan asupan pangan yang bersumber dari pangan hewani, kandungan tidak bergizi, dan rendahnya kandungan energi pada complementary foods. Praktik pemberian makanan yang tidak memadai, meliputi pemberian makanan yang jarang, pemberian makanan yang tidak adekuat selama dan setelah sakit, konsistensi pangan yang terlalu ringan, kuantitas pangan yang tidak mencukupi, pemberian makan yang tidak berespon. Bukti menunjukkan keragaman diet yang lebih bervariasi dan konsumsi makanan dari sumber hewani terkait dengan pertumbuhan linier. Analisa terbaru menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerapkan diet yang beragam, termasuk diet yang diperkaya nutrisi pelengkap, akan meningkatkan asupan gizi dan mengurangi risiko stunting.

d. Pemberian ASI Eksklusif

Masalah-masalah terkait praktik pemberian ASI meliputi delayed Initiation, tidak menerapkan ASI Eksklusif, dan penghentian dini konsumsi ASI. Sebuah penelitian membuktikan bahwa menunda inisiasi menyusui (delayed initiation

) akan meningkatkan kematian bayi. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain, baik berupa air putih, jus, ataupun susu selain ASI. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Setelah 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping yang adekuat sedangkan ASI dilanjutkan sampai usia 24 bulan. Menyusui yang berkelanjutan selama dua tahun memberikan kontribusi signifikan terhadap asupan nutrisi penting pada bayi.

e. Faktor Infeksi

Beberapa contoh infeksi yang sering dialami yaitu infeksi enterik seperti diare, enteropati, dan cacing, dapat juga disebabkan oleh infeksi pernapasan (ISPA), malaria, berkurangnya nafsu makan akibat serangan infeksi dan inflamasi. Penyakit infeksi akan berdampak pada gangguan masalah gizi. Infeksi klinis menyebabkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan anak yang memiliki riwayat penyakit infeksi memiliki peluang mengalami stunting.

2. Faktor Tidak Langsung

a. Faktor Sosial Ekonomi

b. Status ekonomi yang rendah dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap anak menjadi kurus dan pendek. Menurut Bishwakarma status ekonomi yang rendah akan mempengaruhi pemilihan makanan yang dikonsumsi sehingga biasanya menjadi kurang bervariasi dan sedikit jumlahnya terutama pada bahan pangan yang berfungsi untuk pertumbuhan anak seperti sumber protein, vitamin dan mineral sehingga meningkatkan risiko kekurangan gizi.

c. Tingkat Pendidikan

Menurut Delmi Sulastri pendidikan ibu yang rendah dapat mempengaruhi pola asuh dan perawatan anak. Selain itu juga berpengaruh dalam pemilihan dan cara penyajian makanan yang akan dikonsumsi oleh anaknya. Penyediaan bahan dan menu makan yang tepat untuk balita dalam upaya peningkatan status gizi akan dapat terwujud bila ibu mempunyai tingkat pengetahuan gizi yang baik. Ibu dengan pendidikan rendah antara lain akan sulit menyerap informasi gizi sehingga anak dapat berisiko mengalami stunting.

d. Pengetahuan Gizi Ibu

Menurut delmi Sulastri menjelaskan bahwa pengetahuan gizi yang rendah dapat menghambat usaha perbaikan gizi yang baik pada keluarga maupun masyarakat sadar gizi artinya tidak hanya mengetahui gizi tetapi harus mengerti dan mau berbuat. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang kebutuhan akan zat-zat gizi berpengaruh terhadap jumlah dan jenis

bahan makanan yang dikonsumsi. Pengetahuan gizi merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap konsumsi pangan dan status gizi. Ibu yang cukup pengetahuannya akan memperhatikan kebutuhan gizi anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

e. Faktor Lingkungan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan sanitasi secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya termasuk mengatasi kejadian stunting.

Lingkungan rumah dapat mempengaruhi stunting dikarenakan oleh stimulasi dan aktivitas yang tidak adekuat, penerapan asuhan yang buruk, ketidakamanan pangan, alokasi pangan yang tidak tepat, rendahnya edukasi pengasuh. Anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air dan sanitasi yang baik beresiko mengalami stunting.

Selain sanitasi lingkungan, faktor kebersihan diri (personal hygiene) juga sangat berpengaruh dalam menentukan kesehatan keluarga. Faktor penemuan sumber air bersih juga merupakan faktor risiko kejadian stunting. Air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk makan dan minum sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan keluarga, termasuk balita. Air yang dapat digunakan tidak keruh, berbau berwarna dan berasa.

Akses jamban keluarga juga berkaitan dengan kejadian stunting. Praktik buang air besar (BAB) pada jamban yang tidak layak atau bahkan masih sembarangan (open defecation free (ODF)) menyebabkan pencemaran lingkungan dan penyebaran bakteri patogen. Selain jamban, pengelolaan limbah cair serta sampah juga berhubungan dengan status kesehatan masyarakat termasuk kejadian stunting.

f. Akses Layanan Kesehatan

Kunjungan ANC adalah frekuensi kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan dengan jumlah kunjungan minimal 6 (enam) kali selama kehamilan dengan distribusi kunjungan pada trimester I sebanyak dua kali, trimester II sebanyak satu kali dan trimester III sebanyak tiga kali dan mendapatkan pelayanan minimal pemeriksaan kehamilan.

Balita yang tidak rutin dan tidak pernah memanfaatkan posyandu akan memiliki kecenderungan 3,5 dan 5,2 kali mengalami stunting. Balita yang rutin di bawa ke posyandu, akan lebih mudah untuk dilakukan screening tumbuh

kembangnya. Sehingga apabila terjadi gangguan tumbuh kembang akan lebih cepat tertangani sehingga meminimalisir dampak yang akan terjadi. Selain itu, dengan aktif ke posyandu, balita juga akan mendapat layanan kesehatan yang sesuai dengan usianya, seperti imunisasi dan layanan gizi.

Selain keaktifan posyandu, kelengkapan status imunisasi juga merupakan risiko stunting, anak yang tidak diimunisasi secara lengkap akan meningkatkan kemungkinan risiko 2,2 kali menderita stunting. Imunisasi dasar sangat penting bagi imunitas balita, dimana sesuai dengan target nasional bahwa imunisasi dasar lengkap harus mencapai target sampai 100,0%. Karena anak yang tidak diimunisasi secara lengkap akan terdapat gangguan kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi karena produksi antibodi menurun mengakibatkan mudahnya bibit penyakit masuk, hal dapat mengganggu produksi berbagai jenis enzim untuk pencernaan makanan.

Tingginya prevalensi stunting di negara berkembang disebabkan karena kebutuhan gizi yang meningkat bersamaan dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas Makanan Pendamping ASI (MP ASI). Berdasarkan kerangka pikir UNICEF Tahun 1990 (lihat Gambar 2.1), penyebab kekurangan gizi pada ibu dan anak dibedakan dalam 3 penyebab yang mendasari, yaitu:

1. Penyebab dasar
 - a. Kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik
 - b. Keluarga tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai, baik dari segi gizi, pangan maupun pendidikan
2. Penyebab tidak langsung
 - a. Ketersediaan pangan rumah tangga yang tidak memadai
 - b. Pola asuh yang tidak memadai
 - c. Pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan yang tidak memadai
3. Penyebab langsung
 - a. Asupan gizi yang tidak memadai
 - b. Penyakit infeksi

Semua kondisi di atas akan berdampak pada status gizi anak yang dalam jangka pendek dapat mempengaruhi mortalitas, morbiditas, serta disabilitas mereka. Sementara dampak jangka panjang dapat mempengaruhi status gizi saat dewasa, kemampuan intelektual, produktivitas ekonomi, kesehatan reproduksi, dan risiko timbulnya penyakit metabolik dan kardiovaskular. Kondisi ini tentu saja dapat mempengaruhi status kesehatan dan gizi antar generasi.

Menurut BKKBN yang berisiko mengalami stunting adalah:

1. Calon Ibu kurang sehat ternyata bisa menjadi penyebab anak stunting. Berikut faktor-faktornya:
 - a. Nutrisi buruk selama prakonsepsi (sebelum kehamilan)
 - b. Tidak tercukupinya gizi baik saat kehamilan dan menyusui
 - c. Hamil usia < 20 tahun atau > 35 tahun
 - d. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu berat bayi lahir <2500 gr
 - e. Infeksi saat kehamilan dan melahirkan
 - f. Kelahiran bayi prematur
 - g. Hipertensi dalam kehamilan
 - h. Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang memungkinkan ukuran dan berat bayi tidak sesuai dengan usia kehamilan
 - i. Kehamilan usia dini
 - j. Kesehatan mental ibu
 - k. Terlalu sering melahirkan
 - l. Preeklamsia
 - m. Jarak kehamilan dan kelahiran yang dekat
2. Lingkungan tempat tinggal tidak higienis. Sanitasi buruk membuat pangan rentan terkontaminasi.
3. Pendekatan keluarga rendah. Keluarga tidak mampu memberikan asupan yang bergizi salah satunya akibat kemiskinan.
4. Lingkungan tempat tinggal tidak memiliki fasilitas kesehatan memadai.
5. Tingkat pendidikan keluarga rendah. Sehingga akses terhadap informasi tetnag pentingnya hidup sehat dan kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang anak sangat minim. Termasuk soal buruknya kualitas makanan, wakt makan tidak teratur, dan porsi makan kurang

D. Penyebab Stunting dilihat dari Segi Remaja Putri dan Ibu Hamil

1. Remaja Putri

Remaja putri berperan penting dalam pencegahan stunting karena mereka adalah calon ibu. Masalah gizi pada remaja putri, seperti kekurangan asupan protein dan zinc, anemia, serta pola makan yang tidak sehat, dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan reproduksi dan kualitas kehamilan di masa depan. Faktor-faktor yang berkontribusi antara lain:

- a. Asupan protein dan zinc yang rendah: Kekurangan kedua zat gizi ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja putri, serta menurunkan cadangan nutrisi yang dibutuhkan saat hamil nanti.
- b. Anemia: Anemia pada remaja putri, terutama akibat kekurangan zat besi, dapat menurunkan fungsi reproduksi dan meningkatkan risiko melahirkan

anak stunting di masa depan. Anemia juga menurunkan kemampuan belajar, daya tahan tubuh, dan produktivitas kerja.

- c. Pola makan tidak teratur dan diet ketat: Kebiasaan tidak sarapan, konsumsi makanan siap saji, serta diet berlebihan untuk menurunkan berat badan dapat menyebabkan status gizi kurang dan anemia.
- d. Kondisi sosial ekonomi: Keterbatasan ekonomi keluarga mempengaruhi akses remaja putri terhadap makanan bergizi dan edukasi kesehatan.
- e. Kurangnya edukasi tentang gizi dan kesehatan reproduksi: Pengetahuan yang rendah tentang pentingnya gizi seimbang dan kesehatan selama masa remaja meningkatkan risiko stunting pada generasi berikutnya.

2. Ibu Hamil

Kesehatan dan status gizi ibu hamil sangat menentukan pertumbuhan janin dan risiko stunting pada anak. Penyebab utama stunting dari sisi ibu hamil meliputi:

- a. Kekurangan gizi kronis (Kurang Energi Kronis/KEK): Ibu hamil dengan status gizi kurang atau KEK berisiko 3 kali lebih besar melahirkan anak stunting. KEK menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan bayi lahir dengan berat badan rendah.
- b. Kekurangan protein, vitamin, dan mineral: Tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi selama kehamilan, terutama protein, zat besi, asam folat, dan zinc, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko stunting.
- c. Anemia: Anemia defisiensi besi pada ibu hamil menghambat pertumbuhan janin, meningkatkan risiko kelahiran prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah, yang semuanya merupakan faktor risiko stunting.
- d. Infeksi selama kehamilan: Infeksi berulang pada ibu hamil, baik akibat bakteri, virus, maupun parasit, dapat menghambat pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau berat badan rendah.
- e. Kurangnya pemeriksaan kehamilan dan akses layanan kesehatan: Minimnya kontrol kehamilan dan akses ke layanan kesehatan menyebabkan deteksi dan penanganan dini masalah gizi ibu menjadi terhambat, sehingga risiko stunting meningkat.
- f. Pola makan tidak seimbang dan edukasi yang kurang: Kurangnya pengetahuan ibu tentang kebutuhan gizi selama hamil menyebabkan asupan makanan tidak memenuhi kebutuhan janin.

E. Dampak Stunting

Kekurangan atau kelebihan zat gizi pada periode usia 0-2 tahun bersifat irreversibel sehingga berdampak pada kualitas hidup jangka pendek dan jangka panjang seorang anak.

Stunting akan memengaruhi perkembangan otak jangka panjang yang selanjutnya berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi sekolah. Selain itu, gangguan pertumbuhan linear akan memengaruhi daya tahan tubuh dan kapasitas kerja. Efek jangka panjang juga berhubungan dengan penurunan kemampuan oksidasi lemak sehingga menyebabkan risiko mengalami obesitas dan penyakit-penyakit degeneratif antara lain hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit-penyakit kardiovaskular.

Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya yakni:

1. Pertumbuhan melambat
2. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
3. Pertumbuhan gigi terlambat
4. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya
5. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya
6. Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
7. Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak perempuan).
8. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

Dampak jangka panjangnya, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak

1. Menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak
2. Kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit
3. Risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan
4. Penyakit jantung
5. Penyakit pembuluh darah
6. Kesulitan belajar
7. Menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak



Gambar 2.2 Dampak Jangka Panjang Stunting

F. Indikator Penentuan Stunting

Stunting dinilai dengan Standar Antropometri Anak yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak yaitu dengan menggunakan indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Untuk menentukan stunting diperlukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan dengan cara dan alat yang sesuai standar serta penentuan umur yang benar. Mengukur panjang/tinggi badan anak harus menggunakan alat ukur dengan kriteria kuat dan tahan lama, mempunyai presisi sampai 0,1 cm. Sudah dikalibrasi dan memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Alat ukur sesuai standar yang dapat digunakan antara lain infantometer (papan panjang badan) untuk mengukur panjang badan anak usia 0-2 tahun dengan cara terlentang dan microtoiselstadiometer untuk mengukur tinggi badan anak usia di atas 2 tahun dengan cara berdiri.

Metode pengukuran yang tidak tepat akan menimbulkan bias pengukuran yang berefek pada ketidakvalidan diagnosis dan tata laksana. Analisis terhadap indeks antropometrik dan pola pertumbuhan dapat mengarahkan ke diagnosis banding stunting. Pendek yang didahului oleh suatu perlambatan pertumbuhan

dapat diperkirakan sebagai stunting dengan menentukan apakah usia berat (weight age) < usia tinggi (height age) < usia kronologis (chronological age).

Setelah dilakukan pengukuran panjang/tinggi badan anak, hasil pengukurannya di plot pada grafik pertumbuhan PB/TB menurut usia dan jenis kelamin dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Berdasarkan standar pertumbuhan WHO dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, panjang badan atau tinggi badan menurut umur dikategorikan atau diklasifikasikan.

Ambang Batas TB/U atau PB/U	Kategori
< - 3 SD	Sangat Pendek (<i>severely stunted</i>)
-3 SD sd < - 2 SD	Pendek (<i>stunted</i>)
- 2 SD sd + 3 SD	Normal
> + 3 SD	Tinggi (<i>tall</i>)

Seorang anak dengan PB/U atau TB/U kurang dari -2 SD berdasarkan jenis kelamin dan umur kronologis diklasifikasikan sebagai berperawakan pendek. Anak pendek merupakan salah satu gejala stunting, untuk mendiagnosis penyebab perawakan pendek karena stunting atau karena penyebab lain maka perlu merujuk anak untuk dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Stunting)

Perawakan pendek yang disebabkan oleh stunting harus segera diatasi masalahnya karena bisa mengakibatkan penurunan fungsi kognitif anak dan juga perubahan fisiologis yang membahayakan di kemudian hari. Pada Balita diatas 2 tahun yang setelah dilakukan konfirmasi dengan indikator status gizi (pertumbuhan) dan indikator perkembangan (tools Buku KIA, MTBS, SDIDTK, Kuesioner Pra Skrining Perkembangan-KPSP), dipantau status infeksiya dan diberikan intervensi tata laksana gizi, bila tidak mengalami perbaikan; ditambah adanya tanda bahaya seperti kelainan anatomi, neuro-developmental atau kecurigaan kelainan hormonal, maka Balita harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dokter spesialis anak. Pemeriksaan perkembangan harus dilakukan sebelum anak dirujuk ke dokter spesialis anak untuk konfirmasi diagnosis.

Gagal tumbuh (*Growth Faltering*) merupakan suatu kejadian yang ditemui pada hampir setiap anak di Indonesia. Gagal tumbuh pada dasarnya merupakan ketidakmampuan anak untuk mencapai berat badan atau tinggi badan sesuai dengan jalur pertumbuhan normal. Kegagalan pertumbuhan yang nyata biasanya

mulai terlihat pada usia 4 bulan yang berlanjut sampai anak usia 2 tahun, dengan puncaknya pada usia 12 bulan.

G. Penilaian Status Gizi

Stunting adalah kondisi saat anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya, yang dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi, infeksi, dan faktor lingkungan lainnya. Penilaian status gizi pada stunting dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah penilaian status gizi secara langsung dan tidak langsung.

1. Penilaian Status Gizi Secara Langsung

Penilaian status gizi secara langsung dapat dilakukan dengan beberapa metode yang dapat memberikan informasi langsung tentang status gizi seseorang. Berikut adalah beberapa metode penilaian status gizi secara langsung yaitu:

a. Antropometri

Antropometri adalah pengukuran tubuh manusia untuk menentukan status gizi. Beberapa pengukuran antropometri yang dapat dilakukan adalah berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar perut, dan lipatan kulit. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan status gizi seseorang.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dapat memberikan petunjuk tentang status gizi seseorang. Misalnya, kulit yang kering dan kusam dapat menunjukkan kekurangan vitamin dan mineral tertentu, sementara rambut yang kusam dan mudah rontok dapat menunjukkan kekurangan protein.

c. Uji laboratorium

Pemeriksaan darah dapat memberikan petunjuk tentang status gizi seseorang. Misalnya, rendahnya kadar hemoglobin dapat menunjukkan kekurangan zat besi, sedangkan kadar serum albumin yang rendah dapat menunjukkan malnutrisi kronis.

2. Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara mengamati gejala atau tanda-tanda yang terkait dengan keadaan gizi seseorang. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penilaian status gizi secara tidak langsung antara lain:

a. Anamnesis

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari pasien atau orang yang merawatnya tentang pola makan, riwayat kesehatan, dan aktivitas fisik.

Informasi ini dapat memberikan gambaran tentang asupan nutrisi, masalah kesehatan yang mempengaruhi status gizi, dan kebiasaan makan yang tidak sehat.

b. Uji fungsional

Tes fungsional dapat memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, tes daya tahan kardiorespirasi dapat memberikan petunjuk tentang kebugaran kardiorespirasi seseorang. Penilaian status gizi secara tidak langsung tidak selalu akurat karena dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti penyakit, obat-obatan, dan kondisi lingkungan.

H. Titik Kritis Periode Emas

Adapun titik kritis yang harus diperhatikan selama periode emas (0-2 tahun) adalah sebagai berikut:

1. Periode dalam kandungan (280 hari)

Ibu hamil adalah kelompok rentan gizi yang memerlukan asupan gizi optimal untuk menjaga status gizi ibu dan mendukung tumbuh kembang janin. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan berbagai masalah serius, seperti gangguan pertumbuhan janin yang berujung pada stunting, peningkatan risiko obesitas dan penyakit degeneratif pada anak saat dewasa, serta komplikasi kehamilan seperti keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan berat badan lahir rendah (BBLR). Janin mengambil nutrisi dari makanan yang dikonsumsi ibu dan cadangan dalam tubuh ibu. Oleh karena itu, ibu hamil perlu menambah jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan janin, serta untuk persiapan menyusui.

Penting bagi ibu untuk memiliki status gizi yang baik sebelum hamil dan mengonsumsi makanan beragam dalam jumlah yang cukup. Hal ini demi memastikan pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan janin yang optimal, dengan target berat badan bayi saat lahir tidak kurang dari 2500 gram dan panjang badan tidak kurang dari 48 cm. Pemantauan berat dan panjang bayi, terutama pada periode emas 0-2 tahun, sangat krusial. Teori Thrifty Phenotype menyebutkan bahwa bayi yang kekurangan gizi dalam kandungan akan mengalami adaptasi metabolisme permanen, yang dapat menyulitkan mereka beradaptasi dengan lingkungan kaya gizi setelah lahir, berisiko obesitas dan gangguan toleransi glukosa. Sebaliknya, risiko obesitas berkurang jika bayi tidak mengonsumsi makanan berlebihan setelah lahir.

2. Periode 0– 6 bulan (180 hari)

Ada dua praktik penting setelah melahirkan untuk kesehatan ibu dan bayi: Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif. IMD adalah proses di mana bayi yang baru lahir diletakkan di dada atau perut ibu dalam waktu satu jam setelah kelahiran, memungkinkan bayi untuk mencari dan menyusu secara alami. Praktik ini sangat bermanfaat karena bayi akan mendapatkan kolostrum, tetesan ASI pertama yang kaya akan zat kekebalan tubuh, melindungi bayi dari alergi dan infeksi. Bagi ibu, IMD membantu mempercepat pemulihan pasca persalinan. Meskipun manfaatnya besar, banyak ibu tidak berhasil melakukan IMD karena kurangnya pengetahuan dan dukungan lingkungan. Kolostrum sendiri merupakan ASI terbaik yang keluar pada hari ke 0-5 setelah lahir.

Setelah IMD, ASI eksklusif dianjurkan, yaitu pemberian ASI saja tanpa makanan lain hingga bayi berusia 6 bulan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pemberian ASI eksklusif, baik dari kondisi bayi (seperti BBLR, kelainan kongenital, atau infeksi) maupun dari kondisi ibu (seperti pembengkakan payudara, kecemasan, kurang gizi, atau ibu bekerja). Faktor lain termasuk kurangnya pengalaman, paritas, usia, status perkawinan, merokok, kegagalan menyusui sebelumnya, kurangnya dukungan keluarga, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang minim, serta faktor sosial budaya dan kebijakan rumah sakit yang tidak mendukung laktasi. WHO merekomendasikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mengurangi risiko kontaminasi. Pemberian ASI eksklusif terbukti menurunkan risiko berbagai penyakit pada anak di kemudian hari, seperti infeksi saluran cerna, alergi, obesitas, dan diabetes, serta bermanfaat bagi ibu dengan mempercepat pemulihan status gizi, menurunkan risiko obesitas, hipertensi, rematoid arthritis, dan kanker payudara.

3. Periode 6–24 bulan (540 hari)

Sejak usia 6 bulan, bayi membutuhkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) karena kebutuhan nutrisi mereka tidak lagi tercukupi hanya dengan ASI. Pengetahuan yang tepat mengenai MP-ASI sangat krusial, mengingat seringnya terjadi kesalahan dalam praktiknya. Memberikan MP-ASI terlalu dini (sebelum 6 bulan) dapat memicu gangguan pencernaan atau diare. Sebaliknya, menunda pemberian MP-ASI (tidak sesuai waktunya) akan menghambat pertumbuhan bayi karena kebutuhan gizi yang semakin meningkat tidak terpenuhi oleh ASI saja, berpotensi menyebabkan kurang gizi. Asupan gizi yang tidak memadai ini merupakan salah satu penyebab utama kegagalan tumbuh kembang anak. Untuk mengatasi masalah gizi, program seperti Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) gratis, baik berupa makanan lokal maupun produk pabrikan

seperti susu dan biskuit, perlu digalakkan, di samping peningkatan pengetahuan ibu tentang makanan bergizi.

Pada usia 6 bulan ke atas, anak berada dalam periode pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, mulai terpapar infeksi, dan secara fisik lebih aktif. Oleh karena itu, kebutuhan gizi mereka harus terpenuhi dengan mempertimbangkan aktivitas dan potensi infeksi. Untuk mencapai gizi seimbang, MP-ASI wajib ditambahkan, sementara ASI tetap diberikan hingga anak berusia 2 tahun. Pengenalan makanan dimulai dengan tekstur lumat pada usia 6 bulan, berlanjut ke makanan lembek, dan bertahap menjadi makanan keluarga saat anak berusia 1 tahun. Ibu harus memahami bahwa pola makan seimbang sejak dini akan memengaruhi selera makan anak di kemudian hari, sehingga pengenalan berbagai jenis makanan pada periode ini sangat penting.

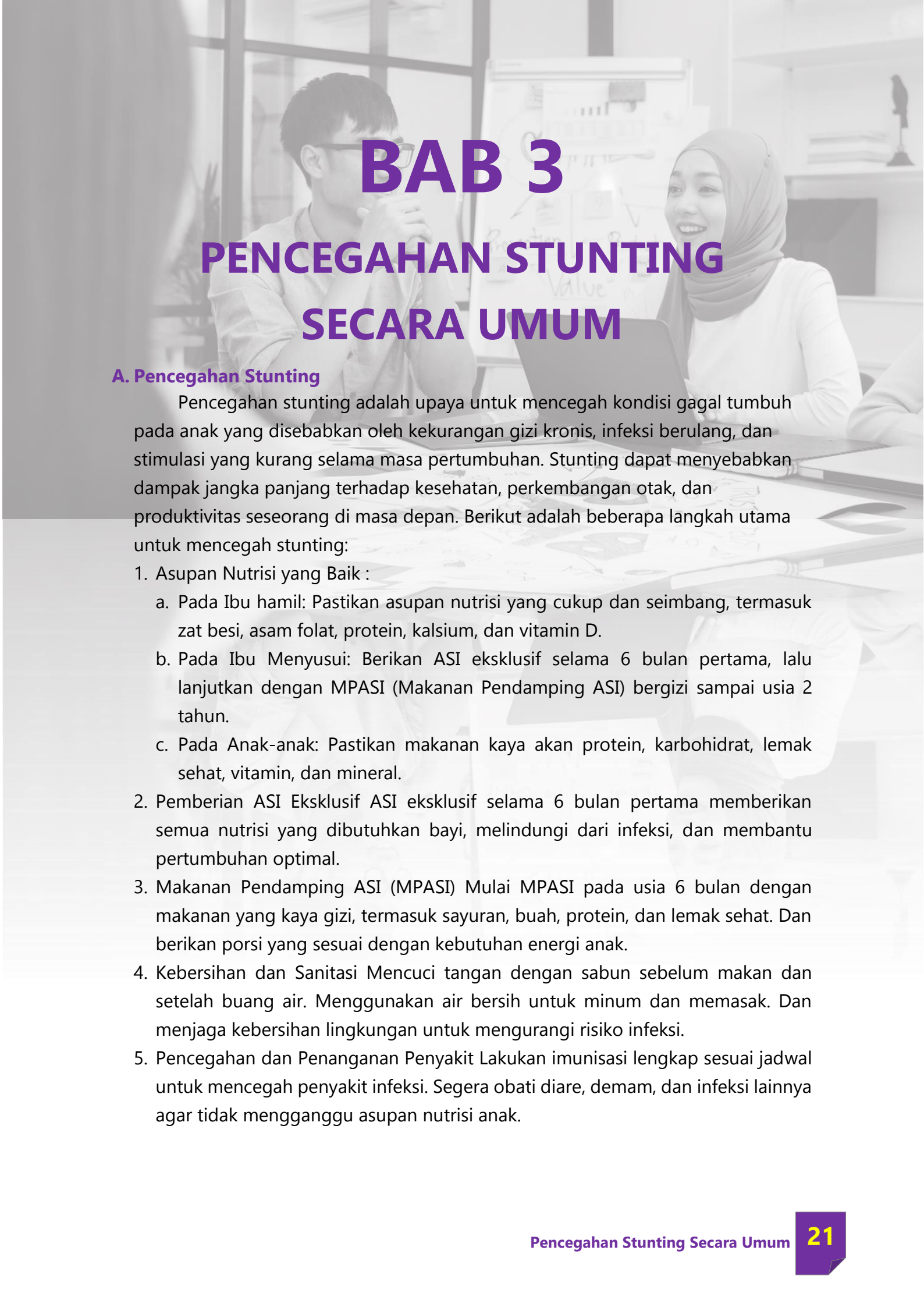
Secara bertahap, variasi makanan untuk bayi usia 6-24 bulan perlu ditingkatkan. Bayi harus mulai diberikan sayuran dan buah-buahan, lauk pauk sumber protein hewani dan nabati, serta makanan pokok sebagai sumber kalori. Jumlah MP-ASI juga harus ditambahkan secara bertahap, namun tidak berlebihan, dan dengan proporsi yang seimbang. Meskipun telah berhasil menyelesaikan fase ASI eksklusif, sangat penting untuk melanjutkan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun. Fase pengenalan MP-ASI merupakan momen krusial di mana anak mulai mengenal makanan padat. Keberhasilan ibu dalam Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama akan sia-sia jika praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), terutama dalam fase pengenalan makanan cair dan lunak, tidak dilakukan dengan baik dan tidak menyediakan makanan yang bernutrisi.

I. Rangkuman Materi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak stunting ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya dan berisiko mengalami keterlambatan perkembangan otak, gangguan metabolisme, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Penyebab stunting sangat kompleks, mencakup faktor langsung seperti kurang gizi, pemberian ASI yang tidak optimal, serta penyakit infeksi, maupun faktor tidak langsung seperti kondisi sosial ekonomi, pendidikan dan pengetahuan gizi ibu, serta lingkungan yang tidak sehat. Remaja putri dan ibu hamil memegang peranan penting, karena kekurangan nutrisi, anemia, pola makan tidak sehat, serta minimnya pemeriksaan kehamilan dapat meningkatkan risiko melahirkan anak stunting.

Dampak stunting terlihat dalam jangka pendek berupa keterlambatan pertumbuhan, konsentrasi yang rendah, serta kerentanan terhadap penyakit. Dalam jangka panjang, stunting berpengaruh pada kecerdasan, produktivitas, hingga risiko penyakit degeneratif. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu difokuskan pada pemenuhan gizi sejak masa kehamilan, pemberian ASI eksklusif, perbaikan pola makan anak, peningkatan sanitasi lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.



BAB 3

PENCEGAHAN STUNTING SECARA UMUM

A. Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting adalah upaya untuk mencegah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang kurang selama masa pertumbuhan. Stunting dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, perkembangan otak, dan produktivitas seseorang di masa depan. Berikut adalah beberapa langkah utama untuk mencegah stunting:

1. Asupan Nutrisi yang Baik :
 - a. Pada Ibu hamil: Pastikan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, termasuk zat besi, asam folat, protein, kalsium, dan vitamin D.
 - b. Pada Ibu Menyusui: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu lanjutkan dengan MPASI (Makanan Pendamping ASI) bergizi sampai usia 2 tahun.
 - c. Pada Anak-anak: Pastikan makanan kaya akan protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral.
2. Pemberian ASI Eksklusif ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan bayi, melindungi dari infeksi, dan membantu pertumbuhan optimal.
3. Makanan Pendamping ASI (MPASI) Mulai MPASI pada usia 6 bulan dengan makanan yang kaya gizi, termasuk sayuran, buah, protein, dan lemak sehat. Dan berikan porsi yang sesuai dengan kebutuhan energi anak.
4. Kebersihan dan Sanitasi Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air. Menggunakan air bersih untuk minum dan memasak. Dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko infeksi.
5. Pencegahan dan Penanganan Penyakit Lakukan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah penyakit infeksi. Segera obati diare, demam, dan infeksi lainnya agar tidak mengganggu asupan nutrisi anak.

6. Pemeriksaan Kehamilan dan Anak Rutin Pemeriksaan kehamilan untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara teratur di Posyandu atau layanan kesehatan.
7. Edukasi dan Kesadaran Orang Tua Edukasi tentang pentingnya gizi, kesehatan, dan stimulasi tumbuh kembang anak. Dan meningkatkan kesadaran akan risiko stunting dan cara mencegahnya.
8. Dukungan Lingkungan dan Kebijakan Program pemerintah seperti pemberian makanan tambahan, fortifikasi pangan, dan bantuan gizi untuk keluarga berisiko.

B. Program Utama Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting

Berikut adalah beberapa program utama pemerintah dalam pencegahan stunting:

1. Pendekatan Multisektoral

Pemerintah memobilisasi berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersinergi dalam menurunkan stunting. Sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur berkolaborasi untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang mendukung pemenuhan gizi serta pengentasan kemiskinan.

2. Intervensi Spesifik dan Sensitif:

Intervensi spesifik langsung menasar masalah gizi, seperti pemberian makanan tambahan bergizi, suplemen zat besi untuk ibu hamil, tablet tambah darah bagi remaja putri, dan imunisasi lengkap untuk bayi, dan Intervensi sensitif mencakup perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan edukasi gizi untuk ibu hamil dan menyusui

3. Pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK):

Program ini menekankan pentingnya asupan gizi sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun, periode kritis dalam mencegah stunting. Pemerintah mendukung inisiatif seperti pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, serta MPASI bergizi setelah enam bulan.

4. Kampanye Edukasi dan Kesadaran:

Pemerintah menggalakkan kampanye melalui media massa dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya stunting. Edukasi ini menargetkan ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga mengenai pentingnya pola makan sehat, sanitasi, serta perilaku hidup bersih.

5. Peningkatan Layanan Kesehatan:

Pemerintah memperluas akses layanan kesehatan di wilayah terpencil melalui puskesmas, posyandu, dan program kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, dan Upaya ini dilengkapi dengan pemberian suplemen vitamin A, zat besi, dan zinc bagi anak-anak untuk mendukung tumbuh kembang mereka

6. Pengentasan Kemiskinan:

Program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Bantuan ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap makanan bergizi.

7. Penguatan Kebijakan dan Anggaran:

Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan stunting, baik melalui program kementerian maupun anggaran desa. Dana desa diarahkan untuk mendukung kegiatan posyandu, sanitasi, dan penyediaan air bersih.

C. Rangkuman Materi

Pencegahan stunting merupakan upaya penting untuk menghindari gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi selama masa pertumbuhan. Langkah pencegahan dapat dilakukan melalui pemenuhan nutrisi yang seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak; pemberian ASI eksklusif; pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi; serta menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin serta imunisasi lengkap juga diperlukan untuk mencegah penyakit yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Dalam rangka menurunkan angka stunting, pemerintah melaksanakan berbagai program yang melibatkan pendekatan multisektoral. Intervensi dilakukan secara spesifik maupun sensitif, mencakup pemberian makanan tambahan bergizi, suplemen bagi ibu hamil dan remaja putri, imunisasi bayi, perbaikan sanitasi, hingga penyediaan air bersih. Perhatian khusus diberikan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, karena periode ini merupakan masa kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Upaya pencegahan stunting juga diperkuat dengan kampanye edukasi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Selain itu, pemerintah memperkuat kebijakan dan alokasi anggaran, termasuk dana desa, untuk mendukung kegiatan posyandu, peningkatan sanitasi, dan penyediaan air bersih. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan prevalensi stunting dapat ditekan sehingga tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

D. Glosarium

Stunting : Anak tumbuh lebih pendek dari normal.

HPK : Masa penting sejak hamil sampai anak usia 2 tahun.

ASI Eksklusif : ASI saja tanpa tambahan makanan/minuman lain selama 6 bulan.

MP-ASI : Makanan tambahan untuk bayi setelah usia 6 bulan.

Sanitasi : Kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit.

Imunisasi : Suntikan atau vaksin untuk mencegah penyakit.

Intervensi Spesifik : Langkah langsung memperbaiki gizi anak.

Intervensi Sensitif: Dukungan tidak langsung, misalnya air bersih atau edukasi gizi.

Posyandu : Tempat layanan kesehatan dasar di desa.

PKH (Program Keluarga Harapan) : Bantuan pemerintah untuk keluarga miskin.

BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) : Bantuan pangan bergizi dari pemerintah.

Tablet Tambah Darah (TTD) : Suplemen zat besi untuk cegah anemia.

BAB 4

PENCEGAHAN STUNTING

SASARAN KADER KESEHATAN

Sebagai kader Posyandu, kita memiliki peran sebagai penyuluh, pencatat dan penggerak. Melalui ketiga peran ini, kader kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat.

A. Sebagai Penyuluh

Dalam upaya pencegahan stunting, kader kesehatan dapat melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu dengan balita, dan keluarganya. Ada beberapa topik atau kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pemeriksaan kehamilan

Kader dapat mengingatkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan (bidan atau dokter) paling sedikit 6 kali selama kehamilan (minimal dua kali diperiksa oleh dokter pada trimester 1 dan 3 dengan menggunakan USG, yaitu 3 bulan pertama kehamilan dan 3 bulan terakhir kehamilan) agar mendapatkan pelayanan kehamilan lengkap dan dapat terdeteksi secara dini bila terjadi masalah dalam kehamilannya untuk segera ditangani. Kader juga perlu mengingatkan ibu hamil untuk membaca dan mempraktikkan pesan yang ada dalam buku KIA.

2. Konsumsi tablet tambah darah (TTD)

Kader dapat mengingatkan ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang sesuai anjuran Pedoman Gizi Seimbang (PGS), serta minum Tablet Tambah Darah (TTD) 1 (satu) tablet setiap hari selama kehamilan untuk mencegah anemia.

Saat minum TTD, sarankan ibu untuk mengonsumsi makanan yang kaya protein dan mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi, serta menghindari minum teh atau kopi yang akan mengganggu penyerapan TTD. Untuk mengurangi mual, sarankan minum TTD saat malam hari sebelum tidur

3. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Ibu hamil memerlukan asupan gizi yang berkualitas dengan susunan makanan dan minuman yang bergizi seimbang. Rata-rata kecukupan gizi ibu hamil per hari tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk bahan makanan dengan menggunakan ukuran rumah tangga sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Bahan makanan	Ibu hamil trimester 1	Ibu hamil trimester 2 dan 3
Makanan pokok	5 Porsi	6 Porsi
Protein hewani, seperti ikan, telur, ayam dan lainnya	4 Porsi	4 Porsi
Protein nabila seperti tempe, tahu, kacang-kacangan	4 Porsi	4 Porsi
Sayuran	4 Porsi	4 Porsi
Buah	4 Porsi	4 Porsi
Minyak/lemak*	5 Porsi	5 Porsi
Gula**	2 Porsi	2 Porsi

- Penggunaan minyak/lemak termasuk santan dibatasi tidak lebih dari porsi yang dianjurkan. Minyak/lemak/santan digunakan dalam pengolahan makanan seperti digoreng, ditumis.
- Penggunaan gula dibatasi tidak lebih dari porsi yang dianjurkan Gula dapat digunakan dalam pengolahan makanan/minuman. Referensi: PGS Ibu hamil.

Sarankan ibu sedapat mungkin mengkonsumsi makanan sesuai porsi yang di anjurkan sesuai usia kehamilan mereka.

4. Kelas Ibu Hamil

Mengingatkan ibu hamil untuk menghadiri Kelas Ibu Hamil agar ibu mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, pemberian ASI (termasuk pentingnya Inisiasi Menyusu Dini - IMD dan manfaat kolostrum), nifas, serta perawatan bayi dari Buku KIA.

5. ASI Eksklusif

Berikan motivasi kepada ibu untuk menyusui dengan pemberian ASI Eksklusif yaitu bayi hanya diberikan Air Susu Ibu (ASI) saja tanpa makanan atau minuman lain, kecuali vitamin, mineral atau obat-obatan dalam bentuk sirup/cair sesuai anjuran tenaga kesehatan hingga usia 6 bulan. ASI dapat diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. Sampaikan pada Ibu pesan-pesan penting tentang ASI yang terdapat dalam Buku KIA.

Jika ada ibu yang telah memberikan susu formula atau makanan tambahan pada anaknya sebelum usia genap 6 bulan, hindari memberikan respon negatif (menyalahkan), namun motivasi ibu untuk kembali hanya memberikan ASI (relaktasi). Dengarkan keluhan ibu mengapa tidak memberikan ASI Eksklusif dan upayakan pemecahan masalahnya. Jika perlu libatkan tenaga kesehatan atau Konselor ASI. Berikan ibu motivasi untuk kembali memberikan ASI.

6. Imunisasi Dasar Bagi Balita

Anak perlu mendapat perlindungan agar terhindar dari penyakit berbahaya dengan cara imunisasi lengkap dan tepat waktu. Informasikanlah dan selalu ingatkan ibu tentang jadwal imunisasi dan mengingatkan ibu agar anak mendapat imunisasi dasar lengkap di Posyandu maupun di fasilitas kesehatan lainnya.

7. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)

Bagilah pengetahuan mengenai pesan-pesan gizi secara sederhana terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), meliputi Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI Eksklusif, dan Makanan Pendamping ASI Inisiasi Menyusu Dini (IMD) (MP ASI) yang bergizi dan aman, ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih sesuai dengan Pedoman Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) Kementerian Kesehatan.

8. Penyuluhan Menyiapkan Makanan yang Aman

Bagikanlah informasi kepada ibu bagaimana menyiapkan makanan bagi anak yang aman. MP ASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih. Ada 5 kunci untuk makanan yang aman, antara lain: (1) jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyiapkan makanan, (2) pisahkan makanan mentah dengan makanan yang sudah matang agar tidak terjadi kontaminasi silang, (3) pastikan masakan aman ($>60^{\circ}\text{C}$ dan $<50^{\circ}\text{C}$), jika makanan pada suhu ruangan dimasak hingga matang, (4) jaga makanan pada suhu yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika sudah lebih dari 2 jam, (5) gunakan air yang bersih dan bahan baku makanan yang aman.



Gambar 4.1 Makanan yang Aman

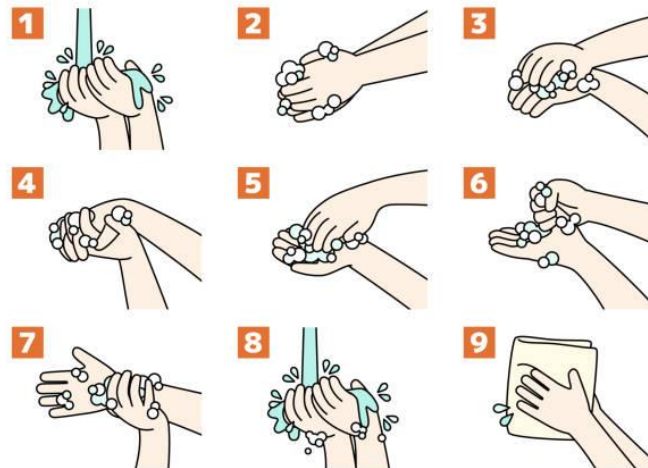
9. Perilaku Sehat dengan Edukasi Agar Tidak Ada Perokok pada Keluarga

Bagilah pengetahuan ini kepada ibu dan keluarganya. Keluarga perokok memiliki risiko memiliki anak stunting yang lebih tinggi dari keluarga tidak perokok. Hal ini disebabkan karena ada pengalihan alokasi belanja makanan bergizi keluarga untuk membeli rokok.

Sebagai perbandingan, harga 12 batang rokok jika dialihkan untuk membeli bahan makanan bisa mendapatkan 2 liter beras, 1 kg telur, 4 papan tempe, dan 1 kg jeruk. Selain itu, asap rokok sendiri mempunyai efek negatif pada anak dan membuat anak mudah terkena penyakit, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan. Anjurkan ibu dan keluarganya untuk tidak merokok, terutama di dekat anak dan di dalam rumah.

10. Penyuluhan Perilaku Bersih dengan cuci tangan pakai sabun





Gambar 4.2 Perilaku Bersih Cuci Tangan Pakai Sabun

11. Penyuluhan penggunaan Jamban Sehat



Gambar 4.3 Penggunaan Jamban Sehat

B. Sebagai Pencatatan

Dalam upaya pencegahan stunting, kader Posyandu dapat melakukan kegiatan preventif berupa deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan balita. Pemantauan ini dapat dilakukan di Posyandu ataupun satuan PAUD lainnya seperti TK, RA, KB, BKB, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jika dari hasil pemantauan ditemukan kasus stunting pada anak, maka laporkanlah segera kepada tenaga kesehatan Puskesmas di wilayah setempat. Ada beberapa hal pencatatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Mampu Mengidentifikasi Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah

Kader sebaiknya mampu mengenali dan mengidentifikasi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu di bawah 2.500 gram dan melaporkan kepada Puskesmas.

2. Mampu Melakukan Pemantauan Pertumbuhan Anak

Lakukan langkah-langkah pemantauan pertumbuhan anak di Posyandu sebagai berikut:

- a. Penimbangan Berat badan bayi
 - b. Penimbangan Berat badan balita
 - c. Pengukuran panjang bayi
 - d. Pengukuran tinggi balita
 - e. Pengukuran lingkar lengan atas (Lila) anak
3. Mampu melakukan pemantauan perkembangan melalui Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK).
4. Melaporkan jika menemukan kasus anak dengan gangguan pertumbuhan

Semua hasil penyimpangan berat badan pengukuran panjang atau tinggi badan melingkar kepala diplot pada buku KIA agar dapat diketahui pertumbuhan dan perkembangannya. Ibu dan kader di Posyandu dapat melakukan stimulasi dan pemantauan perkembangan anak dengan menggunakan Buku KIA. Buku KIA yang juga dapat digunakan sebagai media informasi untuk keluarga/masyarakat.

Bila ditemukan adanya masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan, misalnya status pertumbuhan tidak naik, checklist perkembangan tidak lengkap, maka balita tersebut dilaporkan dan dirujuk kepada tenaga kesehatan di Puskesmas untuk memastikan status pertumbuhan dan perkembangannya, serta mendapatkan penanganan lebih lanjut.

C. Sebagai Penggerak

Dalam upaya pencegahan stunting peran kader sebagai pengarah diharapkan dapat mendorong terlaksananya promosi kesehatan dan penjelasan stunting di wilayah masing-masing. Inisiatif yang dapat dilakukan kader sebagai penggerak, antara lain:

1. Melakukan kunjungan rumah dalam rangka:
 - a. Memantau balita dengan masalah gizi atau menderita penyakit infeksi yang sudah diberikan intervensi (contoh: memastikan Makanan Tambahan dikonsumsi habis oleh balita).
 - b. Mendatangi balita yang tidak hadir ke Posyandu.
2. Aktif menyampaikan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ke petugas kesehatan di Puskesmas.

3. Terlibat aktif dalam rembuk stunting desa agar dapat menyampaikan gagasan dan usulan kegiatan dan kerjasama dengan pihak desa dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan stunting.
4. Mengusulkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan, pendidikan gizi, pengadaan jamban sehat, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi bumil KEK dan balita berat tidak naik berat badannya (T), badan kurang dan gizi kurang.
5. Mengusulkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan, pendidikan gizi, pengadaan jamban sehat, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi bumil KEK dan balita berat tidak naik berat badannya (T), badan kurang dan gizi kurang.
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung pencegahan stunting lintas sektor seperti memastikan ketahanan pangan keluarga (3K: Kolam, Kandang, Kebun) dan kerjasama dengan program lintas sektor lainnya.
7. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan satuan PAUD (seperti PAUD, Taman Kanak-kanak/TK, Raudhatul Athfal/RA, maupun Satuan PAUD Sejenis/SPS), Kader Pembangunan Manusia (KPM), ataupun Bina Keluarga Balita (BKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pertumbuhan.
8. Mengajak peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat
9. Melakukan perencanaan tahunan kegiatan posyandu bersama tenaga kesehatan Puskesmas.
10. Contoh menu PMT:

Bubur Sup Daging Kacang Merah



RESEP UNTUK 3 PORSI

Bahan

- 50 gr (6 sdm) nasi
- 30 gr (3 sdm) daging ayam cincang
- 25 gr (1/2 butir) telur ayam
- 10 gr (1 sdm) buncis
- 10 gr (1 sdm) wortel
- 10 gr (1 sdm) kacang merah
- 10 gr (1 batang) bawang daun
- 1 batang seledri
- 300 ml kaldu ayam
- 2.5 gr (1/2 sdt) minyak untuk menumis.

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak
98 kkal	45.1 gr	3.6 gr

*kontribusi energi sebesar 48,7% dari kebutuhan makanan tambahan sehari.

Cara Membuat

- Didihkan air kaldu ayam, masukkan kacang merah dan masak sampai empuk
- Tumis bumbu halus sampai harum, masukkan daging ayam cincang, masak sampai berubah warna
- Masukkan tumisan daging ayam kedalam air kaldu masak sampai daging empuk
- Masukkan nasi, buncis, dan wortel.
- Tambahkan kocokan telur, aduk merata dan masak sampai matang
- Haluskan bubur sampai tekstur yang diinginkan, lalu sajikan

Bumbu Halus

- 2 siung bawang merah
- 2 siung bawang putih

Buah

- 100 g (2 buah) jeruk diambil sarinya

Bubur Soto Ayam Santan



RESEP UNTUK 3 PORSI

Bahan

- 60 gr (6 sdm) Nasi putih
- 45 gr (4.5 sdm) Daging ayam cincang
- 30 gr (1 buah kecil) Tahu
- 30 gr (3 sdm) Labu siam
- 15 gr (1.5 sdm) wortel
- 1lembar Salam
- 1 batang Sereh
- 1lembar Daun jeruk
- 5 gr (1 sdm) Minyak goreng
- 30 ml (3 sdm) Santan
- 300 ml Air kaldu ayam

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak
96 kkal	4.6 gr	4.1 gr

*kontribusi energi sebesar 48% dari kebutuhan makanan tambahan sehari.

Cara Membuat

- Tumis bumbu halus sampai harum, masukan ayam cincang sampai berubah warna.
- Masukan air kaldu ayam, santan, salam, sereh dan daun jeruk masak sampai mendidih.
- Masukan nasi, tahu dan labu siam dan wortel yang sudah diiris kecil-kecil masak sampai semua bahan matang dan empuk.
- Haluskan sampai tekstur yang diinginkan. Sajikan selagi hangat.

Bumbu Halus

- 1 siung bawang merah
- 1 siung bawang putih
- 1 cm Kunyit
- 1 cm Jahe

Buah

- 100 gr (3 buah kecil) Jeruk (diambil sarinya)

Bubur Sup Daging Kacang Merah



RESEP UNTUK 3 PORSI

Bahan

- 50 gr (6 sdm) nasi
- 30 gr (3 sdm) daging ayam cincang
- 25 gr (1/2 butir) telur ayam
- 10 gr (1 sdm) buncis
- 10 gr (1 sdm) wortel
- 10 gr (1 sdm) kacang merah
- 10 gr (1 batang) bawang daun
- 1 batang seledri
- 300 ml kaldu ayam
- 2.5 gr (1/2 sdt) minyak untuk menumis.

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak
98 kkal	45.1 gr	3.6 gr

*kontribusi energi sebesar 48,7% dari kebutuhan makanan tambahan sehari.

Cara Membuat

- Dididihkan air kaldu ayam, masukkan kacang merah dan masak sampai empuk
- Tumis bumbu halus sampai harum, masukkan daging ayam cincang, masak sampai berubah warna
- Masukkan tumisan daging ayam kedalam air kaldu masak sampai daging empuk
- Masukkan nasi, buncis, dan wortel.
- Tambahkan kocokan telur, aduk merata dan masak sampai matang
- Haluskan bubur sampai tekstur yang diinginkan, lalu sajikan

Bumbu Halus

- 2 siung bawang merah
- 2 siung bawang putih

Buah

- 100 g (2 buah) jeruk diambil sarinya

Mie Kukus Telur Puyuh



RESEP UNTUK 3 PORSI

Bahan

- 85 gr (3 bungkus) mie instan batita atau mie keriting
- 60 gr (6 butir) butir Telur puyuh
- 50 gr (5 sdm) wortel parut
- 50 gr (5 sdm) keju parut
- 10 gr (1 batang) bawang daun iris
- Minyak untuk menggoreng
- Bumbu mie instan batita secukupnya
- 300 ml Air

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak
135 kkal	5.1 gr	7.6 gr

*kontribusi energi sebesar 48% dari kebutuhan makanan tambahan sehari.

Cara Membuat

- Dididihkan air sebanyak 300 ml masukkan mie instan batita atau mie keriting sampai lunak dan matang.
- Masak mie instan batita atau mie keriting hingga matang.
- Tambahkan wortel parut, bawang daun, keju parut, dan bumbu mie instan batita secukupnya, kembali aduk sampai merata
- Masukkan 1 sdm adonan mie ke dalam wadah tahan panas yg sudah diolesi minyak dan masukan telur puyuh yang sudah direbus. Lakukan sampai adonan habis
- Kukus selama 15 menit Setelah matang boleh langsung dikonsumsi atau digoreng sampai kuning keemasan. Hidangkan.

Buah

- 150 gr (6 potong kecil) Pepaya

Nasi Tim Ikan Tuna Telur Puyuh



**RESEP UNTUK
3 PORSI**

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak
120	4.6	4.3
kkal	gr	gr

*kontribusi energi sebesar 40% dari kebutuhan makanan tambahan sehari

Cara Membuat

- Masukkan nasi, ikan tuna, telur puyuh, minyak kelapa ke dalam mangkok tim
- Tambahkan air kaldu
- Masukkan wortel dan tomat, tim hingga matang
- Angkat, sajikan dengan saos papaya.

Bahan

- 115 gr (12 sdm) nasi putih
- 30 gr (1 potong kecil) ikan tuna segar, haluskan
- 30 gr (3 butir) telur puyuh
- 15 gr (1 potong besar) wortel
- 10 gr (1 buah sedang) tomat
- 7.5 gr (1.5 sdt) minyak kelapa
- 75 cc (1/3 gelas belimbing) kaldu ayam
- 50 gr (1/2 potong) pepaya, haluskan

Buah

- 180 gr (1 potong besar) semangka

Gambar 4.4 Menu PMT

D. Rangkuman Materi

Kader kesehatan, khususnya kader Posyandu, memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting melalui fungsi sebagai penyuluh, pencatat, dan penggerak di masyarakat. Sebagai penyuluh, kader memberikan edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, konsumsi tablet tambah darah, pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, imunisasi dasar, hingga praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Kader juga menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan, menyiapkan makanan dengan aman, serta mengurangi risiko paparan asap rokok dalam keluarga.

Selain itu, kader berperan sebagai pencatat yang melakukan deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkaran lengan atas, serta pemantauan perkembangan melalui Buku KIA. Hasil pencatatan digunakan untuk mengidentifikasi kasus stunting sejak dini sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan di Puskesmas. Dengan demikian, data yang akurat dan

pemantauan berkelanjutan menjadi kunci dalam mencegah dan menanggulangi stunting secara efektif.

Sebagai penggerak, kader berperan mendorong keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak dalam mendukung pencegahan stunting. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan rumah, keterlibatan dalam rembuk desa, pengusulan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan gizi dan sanitasi, serta koordinasi dengan berbagai lembaga seperti PAUD, Bina Keluarga Balita, dan tokoh masyarakat. Peran aktif kader dalam menggerakkan masyarakat diharapkan dapat memperkuat promosi kesehatan, meningkatkan kesadaran kolektif, dan mempercepat penurunan prevalensi stunting di tingkat desa maupun nasional.

E. Glosarium

Buku KIA	: Buku Kesehatan Ibu dan Anak berisi catatan tumbuh kembang.
Pedoman Gizi Seimbang (PGS)	: Aturan pola makan sehat dan bergizi.
PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)	: Cara memberi makan bayi dan balita dengan tepat.
IMD (Inisiasi Menyusu Dini)	: Bayi menyusu segera setelah lahir.
MP-ASI	: Makanan tambahan bergizi untuk bayi setelah 6 bulan.
BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)	: Bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram.
SDIDTK	: Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak.
PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	: Makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil kurang gizi.
3K (Kolam, Kandang, Kebun)	: Program ketahanan pangan keluarga dari desa.

BAB 5

PENCEGAHAN STUNTING SASARAN REMAJA PUTRI

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Pada masa ini akan terjadi pertumbuhan fisik, mental, dan emosional berubah sangat cepat. Pada saat proses pematang fisik, terjadilah perubahan komposisi tubuh baik tinggi badan maupun berat badan yang akan mempengaruhi status kesehatan dan gizi seseorang. Oleh sebab itu saat remaja asupan gizi dan pola hidup remaja harus diperhatikan. Menurut UNICEF remaja dimulai sejak usia 10 tahun hingga 19 tahun.

Masa remaja merupakan jendela kesempatan kedua yang berdampak pada lintasan perkembangan (termasuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif), membentuk kebiasaan masa depan dan mengimbangi beberapa pengalaman masa kanak-kanak yang buruk, kesempatan kedua setelah anak usia dini. Oleh sebab itu perlu perhatian khusus terhadap remaja.

A. Skrining Anemia Melalui Pemeriksaan HB

Skrining Anemia bertujuan untuk deteksi dini anemia pada remaja putri. Anemia merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin (Hb) dalam darah rendah atau dibawah normal. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen untuk diedarkan dari paru-paru ke seluruh tubuh. Anemia dapat diketahui melalui pemeriksaan kadar Hemoglobin. Nilai normal kadar hemoglobin pada remaja putri yaitu 12 g/dL. Remaja putri dikatakan anemia jika kadar Hb <12gr/dL.

Deteksi dini anemia dilakukan untuk mengurangi dampak anemia seperti penurunan kekebalan tubuh, konsentrasi, prestasi dan produktivitas, yang ditandai dengan 5L (lemah, letih, lesu, lelah, lalai), mudah mengantuk, sulit konsentrasi, sering pusing, mata berkunang-kunang, pucat pada wajah, kelopak mata, bibir, kulit, kuku dan telapak tangan. Remaja putri yang anemia beresiko menjadi calon ibu yang anemia. Ibu yang anemia beresiko tinggi mengalami kematian ibu melahirkan, bayi prematur, Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

B. Konsumsi tablet tambah darah (TTD)

Suplementasi TTD pada Rematri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi asupan zat besi untuk mencegah anemia yang dapat menyebabkan:

1. Menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi
2. Menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak
3. Menurunnya prestasi belajar
4. Dalam jangka panjang jika rematri tersebut menjadi ibu hamil maka akan menjadi ibu hamil yang anemia juga yang akan meningkatkan risiko persalinan, kematian ibu dan bayi, serta infeksi penyakit.

Pemberian TTD dengan dosis yang tepat dapat mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi di dalam tubuh. Pemberian TTD dilakukan pada remaja putri mulai dari usia 12-18 tahun di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) melalui UKS/M. Dosis pencegahan dengan memberikan satu tablet tambah darah setiap minggu selama 52 (lima puluh dua) minggu.

C. Edukasi Gizi Seimbang

Pada masa remaja, kebutuhan zat gizi lebih tinggi dibandingkan dari tahap kehidupan lainnya. Pada masa remaja terjadi growth spurt, yaitu periode peningkatan laju pertumbuhan. Oleh karena itu, pada masa ini zat gizi yang lebih tinggi harus diberikan untuk memenuhi pencapaian potensi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Apabila salah satu komponen zat gizi tak terpenuhi pada periode ini, salah satunya dapat mengakibatkan lambatnya proses pubertas, yakni gangguan proses kematangan seksual berupa tanda-tanda seks sekunder dan kemampuan reproduksi. Akibat lainnya adalah terjadinya hambatan pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya

1. Mengajarkan remaja tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan protein hewani (daging, ikan, telur, susu), sayuran hijau, buah-buahan, serta sumber karbohidrat kompleks.
2. Menekankan pentingnya sarapan dan menghindari kebiasaan makan yang tidak sehat (misalnya, terlalu banyak makanan cepat saji, makanan tinggi gula dan garam).
3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin D, dan zink untuk pertumbuhan dan perkembangan.
4. Edukasi tentang penundaan usia pernikahan dan kehamilan dini untuk memberikan waktu bagi tubuh remaja putri untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum menghadapi kehamilan.

5. Mendorong aktivitas fisik yang cukup.
6. Menghindari kebiasaan merokok, minum alkohol, atau penyalahgunaan narkoba yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan kesehatan secara keseluruhan.
7. Cukup istirahat.
8. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga penting untuk remaja. Infeksi berulang dapat mengganggu penyerapan nutrisi.
9. Menganjurkan remaja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan memantau status gizi mereka (misalnya, Indeks Massa Tubuh/IMT)



Gambar 5.1 Gizi Seimbang pada Makanan

Remaja putri memegang peran yang sangat krusial dalam upaya pencegahan stunting. Kesehatan dan gizi mereka saat ini akan sangat memengaruhi kesehatan janin di masa depan jika mereka hamil. Untuk memastikan generasi mendatang tumbuh optimal dan bebas stunting, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh remaja putri:

1. Perhatikan Gizi Seimbang Sejak Dini

Ini adalah fondasi utama. Remaja putri seringkali mengabaikan asupan gizi karena fokus pada penampilan atau aktivitas. Padahal, kebutuhan gizi mereka sangat tinggi untuk pertumbuhan dan persiapan masa depan.

- a. Konsumsi Makanan Kaya Zat Besi: Remaja putri rentan mengalami anemia (kekurangan zat besi) karena menstruasi. Anemia pada remaja putri bisa berlanjut menjadi anemia pada ibu hamil, yang meningkatkan risiko bayi lahir stunting. Konsumsi daging merah, hati, ikan, telur, sayuran hijau gelap (bayam, daun singkong), dan kacang-kacangan.

- b. Asupan Protein Cukup: Protein penting untuk pertumbuhan tubuh dan perkembangan organ. Pastikan mengonsumsi protein hewani (ayam, ikan, telur, susu, daging) dan protein nabati (tahu, tempe, kacang-kacangan).
 - c. Sumber Karbohidrat Kompleks: Pilih nasi merah, ubi, roti gandum, atau jagung sebagai sumber energi utama.
 - d. Lemak Sehat: Konsumsi lemak sehat dari alpukat, ikan berlemak, atau minyak nabati.
 - e. Buah dan Sayur: Pastikan asupan vitamin dan mineral dari berbagai jenis buah dan sayur tercukupi setiap hari.
 - f. Hindari Diet Ekstrem: Jangan melakukan diet ketat tanpa pengawasan ahli yang bisa menyebabkan kekurangan gizi.
2. Minum Tablet Tambah Darah (TTD)
3. Jaga Kebersihan Diri dan Lingkungan
- Kesehatan dan kebersihan sangat berkaitan dengan penyerapan nutrisi dan pencegahan penyakit.
- a. Cuci Tangan Pakai Sabun: Biasakan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet.
 - b. Kebersihan Menstruasi: Jaga kebersihan organ intim selama menstruasi untuk mencegah infeksi.
 - c. Lingkungan Bersih: Pastikan lingkungan tempat tinggal bersih dan memiliki akses sanitasi yang layak.
4. Periksa Kesehatan Secara Berkala
- a. Skrining Kesehatan: Manfaatkan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas untuk skrining kesehatan remaja, termasuk pemeriksaan status gizi (tinggi badan, berat badan) dan skrining anemia.
 - b. Vaksinasi: Pastikan mendapatkan imunisasi yang direkomendasikan, seperti Tetanus Toxoid (TT) yang penting untuk persiapan kehamilan.
5. Hindari Pernikahan Dini
- Pernikahan di usia remaja (di bawah 18 tahun) sangat berisiko tinggi.
- a. Kesiapan Fisik dan Mental: Tubuh remaja putri yang belum matang sepenuhnya belum siap untuk hamil dan melahirkan. Ini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan kelahiran bayi stunting.
 - b. Pengetahuan dan Kematangan: Pernikahan dini juga seringkali berarti kurangnya pengetahuan dan kematangan mental dalam mengasuh anak, yang bisa berdampak pada pola asuh dan gizi anak.
6. Pahami Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
- Remaja putri perlu memahami bahwa 1000 HPK (dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun) adalah periode kritis yang menentukan tumbuh

kembang anak. Gizi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat memengaruhi kualitas HPK ini.

Dengan memperhatikan semua poin di atas, remaja putri dapat menjaga kesehatan dan gizi mereka dengan baik, sehingga siap untuk menjadi ibu yang sehat di masa depan dan melahirkan generasi yang bebas stunting.

D. Kebersihan dan kesehatan yang penting dijaga bagi remaja

1. Rambut sehat. Agar rambut sehat, keramas sekurangnya 2x seminggu dan gunakan shampoo yang sesuai.
2. Jerawat. Jerawat merupakan penyakit kulit yang biasa dialami oleh para remaja. Jerawat terjadi pada saat saluran/pori-pori kulit tersumbat, disebabkan karena produksi minyak meningkat yang jika tidak dibersihkan akan menumpuk dan menimbulkan jerawat.
3. Keringat. Keringat merupakan hal normal dan penting untuk menjaga suhu tubuh. Di usia pubertas produksi meningkat, sehingga jika bercampur dengan kotoran atau daki dan bakteri akan membuat tubuh menjadi bau (bau badan/bb). Masalah ini dapat diatasi dengan cara mandi ataupun menggunakan produk yang dapat mencegah timbulnya bau badan, seperti deodoran, bedak bb, ataupun cara tradisional air rendaman kapur sirih.
4. Kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan, bakteri dan kekeringan. Kulit perlu dirawat agar tidak rusak dengan cara: hindari sinar matahari langsung (berlebihan), terutama saat matahari terik.
5. Mandi dan kebersihan tangan serta kaki. Mandi dapat membersihkan debu, minyak dari kulit, menghilangkan bakteri serta meningkatkan kesegaran tubuh. Mandi sekurang kurangnya 2x sehari, gunakan sabun dan air bersih.
6. Menggosok gigi. Gosok gigi sebaiknya dilakukan setelah makan dan sebelum tidur malam. Cara terbaik merawat gigi adalah dengan mengunjungi dokter gigi, minimal 6 bulan sekali.
7. Merawat alat kelamin. Alat kelamin adalah milik pribadi yang berperan penting dalam proses reproduksi sehingga harus dirawat dan dibersihkan, sebab jika tidak akan menimbulkan infeksi dan bau tidak sedap. Perilaku lain yang perlu diperhatikan dalam perawatan alat kelamin antara lain membiasakan diri untuk tidak mengenakan celana yang terlalu ketat (celana berbahan kulit, stretch, jeans, beludru) dalam waktu yang lama, menghindari duduk di area yang bersuhu tinggi (panas) dan mengganti pakaian dalam setiap 2 kali sehari. Bagi remaja puteri di himbau untuk mengganti pembalut setiap 3-4 kali dalam sehari.
8. Kebersihan pakaian. Pakaian yang bersih akan membuat kita nyaman memakainya, enak dipandang dan juga menambah percaya diri. Bila jarang

mengganti pakaian akan menyebabkan tumbuhnya jamur pada kulit dan menimbulkan bakteri pemicu bau badan.

9. Istirahat. Tidur diperlukan tubuh untuk menggantikan bagian-bagian tubuh yang kelelahan sehingga dapat menghilangkan ketegangan atau stress yang akan membuat badan menjadi kembali segar. Tidur dalam jumlah yang cukup sangat penting bagi kesehatan fisik dan emosional.
10. Olahraga. Olahraga merupakan upaya untuk menjaga kesehatan karena akan membuat tubuh bugar, kuat, dan lentur. Selain itu juga dapat memelihara berat badan, menambah tenaga, memperbaiki sirkulasi tubuh, memperkuat tulang dan otot.

E. Olah raga dan rekreasi

Menurut standar internasional, untuk dapat mendapatkan manfaat dari rekreasi fisik atau olahraga, sebaiknya melakukan olah raga selama 20 menit, setidaknya tiga kali seminggu. Olahraga tersebut harus membuat kita sedikit terengah-engah. Kita perlu melakukan "ujian berbicara" – jika kita tidak dapat berbicara saat berolahraga, ini berarti olahraga tersebut terlalu berat. Berolahraga tiga kali seminggu selama 20 menit adalah batas minimal untuk kebugaran. Waktu yang anda habiskan untuk berolahraga tergantung kepada apa yang ingin anda capai. Meningkatkan intensitas olahraga secara bertahap. Misalnya berlari lebih cepat atau lebih jauh setiap minggu atau menambah jumlah aktivitas yang dilakukan.

Olahraga dan rekreasi dapat meningkatkan kesehatan fisik termasuk melatih jantung agar tetap sehat dan kuat, mengurangi lemak tubuh, mempertahankan berat yang sehat, dan mempertahankan setiap organ untuk tetap kuat dan sehat. Olahraga dan rekreasi juga dapat meningkatkan kesehatan psikologis dan bila secara rutin dilakukan akan menghasilkan zat kimia alami di dalam tubuh yang membantu kita menjadi lebih rileks dan mengurangi stres. Berolahraga secara rutin dan berekreasi dapat menjadi sangat menyenangkan, membuat kita lebih bahagia; dapat membangun dan meningkatkan relasi kita dengan orang lain; dan meningkatkan kepercayaan diri serta keterampilan kita

F. Prakonsepsi

Prakonsepsi merupakan penggabungan dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum, konsepsi yang berarti pertemuan sel telur wanita dan sel sperma pria. Prakonsepsi adalah masa sebelum terjadi pertemuan sel telur atau diasumsikan sebagai wanita usia subur yang siap menjadi seorang ibu. Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum hamil atau masa sebelum terjadi pertemuan sel ovum

(sel telur) dengan sperma. Wanita prakonsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang siap menjadi seorang ibu. Kebutuhan gizi pada masa ini berbeda dengan masa anak-anak, remaja, ataupun lanjut usia. Perbaikan kesehatan prakonsepsi berdampak pada peningkatan kesehatan reproduksi dan dapat menurunkan resiko pengeluaran biaya yang mungkin muncul karena masalah kesehatan reproduksi. Pelayanan prakonsepsi dianggap sebagai komponen utama pelayanan kesehatan pada wanita usia subur.

Masa pranikah dapat dikaitkan dengan masa prakonsepsi, karena setelah menikah wanita akan segera menjalani proses konsepsi. Masa prakonsepsi merupakan masa sebelum kehamilan. Periode prakonsepsi adalah rentang waktu dari tiga bulan hingga satu tahun sebelum konsepsi dan idealnya harus mencakup waktu saat ovum dan sperma matur, yaitu sekitar 100 hari sebelum konsepsi. Status gizi wanita usia subur selama tiga sampai enam bulan 8 9 pada masa prakonsepsi merupakan kunci kelahiran bayi normal dan sehat.

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), perencanaan kehamilan sehat adalah kehamilan yang direncanakan pada usia ideal reproduksi (20-35 tahun), dengan jarak kelahiran yang memadai (>2 tahun) dan kesiapan optimal baik mental, fisik, sosial, dan ekonomi calon ibu dan ayah.

Persiapan kesehatan pranikah

1. Persiapan fisik

a. Status kesehatan

Kesehatan seseorang dapat mempengaruhi proses kehamilan dan kualitas kehidupan dari keturunannya. Dengan mengetahui kondisi kesehatan pasangan dapat membuat perencanaan membangun rumah tangga menjadi lebih matang. Pemeriksaan kesehatan tersebut dapat dilakukan sebelum kehamilan, tetapi lebih baik dilakukan dalam waktu tiga sampai enam bulan sebelum menikah sehingga dapat mengambil keputusan lebih baik setelah mengetahui risiko kesehatan yang mungkin dialami oleh calon pasangan apabila tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Status kesehatan dapat diketahui dengan memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan terdekat, puskesmas, rumah sakit atau poliklinik kebidanan dan dilakukan rutin di tempat pelayanan tersebut. Status kesehatan meliputi persiapan tanda-tanda vital, pemeriksaan status gizi (tinggi badan, berat badan, IMT, LiLA, tanda-tanda anemia, pemeriksaan golongan darah rutin, pemeriksaan urin, dan pemeriksaan lain atas indikasi gula darah, malaria, TORCH, hepatitis B, HIV/AIDS, tiroid dan lain-lain.

b. Status gizi

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi. Penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi.

Persiapan gizi penting untuk dilakukan guna memastikan calon ibu sudah melakukan perbaikan status gizi sebelum hamil. Pada persiapan gizi terlebih dahulu diukur status gizi ibu, kemudian petugas kesehatan menghitung IMT sebagai dasar memberikan konseling gizi seimbang. Dalam persiapan gizi, calon pengantin diberikan edukasi mengkonsumsi asam folat untuk menghindari terjadinya defisiensi asam folat yang dapat menyebabkan gangguan pada masa organogenesis.

c. Imunisasi TT

Vaksin TT adalah merupakan vaksin yang mengandung atau berisi kuman toksoid tetanus yang telah dimurnikan yang terabsorpsi atau terserap ke dalam 3 mg/ml aluminium fosfat. Imunisasi TT merupakan program yang diwajibkan untuk calon pengantin sebagai syarat mendaftar menikah. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum pada bayi baru lahir.

d. Usia

Usia ideal untuk menikah bagi wanita adalah 20-35 tahun. Wanita yang menikah di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan.

e. IMT

IMT digunakan untuk mengukur berat badan ideal calon pengantin. IMT dihitung dengan rumus:

$$\text{IMT} = \text{Berat Badan (kg)} / \text{Tinggi Badan (m)}^2$$

Nilai IMT normal adalah 18,5-22,9 kg/m². Calon pengantin dengan IMT Nilai IMT normal adalah 18,5-22,9 kg/m². Calon pengantin dengan IMT <18,5 kg/m² berisiko mengalami kekurangan gizi, sedangkan calon pengantin dengan IMT ≥23 kg/m² berisiko mengalami obesitas.

f. LiLA (Lingkar Lengan Atas)

Lila digunakan untuk mengukur status gizi calon pengantin wanita. Nilai Lila yang normal adalah ≥23,5 cm. Calon pengantin wanita dengan Lila dengan Lila <23,5 cm berisiko mengalami kekurangan gizi dan anemia, yang dapat mempengaruhi kesehatan kehamilan dan persalinan.

g. Kadar Hemoglobin

Kadar hemoglobin normal untuk wanita adalah 12-16 g/dL. Calon pengantin wanita dengan kadar hemoglobin <12 g/dL berisiko mengalami anemia, yang dapat mempengaruhi kesehatan kehamilan dan persalinan

2. Persiapan psikologi

Masalah tumbuh dan kembang di Indonesia salah satunya disebabkan rendahnya pengetahuan orang tua dan tidak adanya persiapan khusus dari pasangan untuk menjadi orang tua. Ketidaksiapan perempuan berhubungan dengan pengalaman baru sebagai seorang ibu yang rendah pengetahuan, terlalu muda dan tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait pemberian makan dan perkembangan anak.

Untuk menghadapi kehamilan yang tidak sebentar lamanya dan dalam perjalanannya nanti akan banyak hal yang baru, maka seorang calon ibu perlu persiapan mental yang baik dengan memperbanyak wawasan mengenai kehamilan. Dengan itu diharapkan para calon ibu lebih siap lahir dan batin untuk menjalani perjuangan selama 9 bulan ke depan. Ia tidak akan lagi merasa khawatir ataupun panik ketika pada trimester pertama banyak merasakan mual dan muntah karena sudah mengetahui ilmu bagaimana mengatasinya. Justru dengan merasakan hal itu seorang calon ibu akan bersyukur dengan segala keluhan dan hal baru yang dihadapinya terkait kehamilan tersebut. Seorang

calon ibu yang sedang hamil adalah pejuang tangguh, berjuang melewati masa-masa yang berbeda.

Wanita usia subur (WUS) dapat menyiapkan kesiapan secara psikis termasuk perubahan yang akan terjadi pada saat kehamilan berlangsung. Dukungan selama kehamilan dapat didapatkan dari orang terdekat seperti suami dan keluarga besar sehingga kesiapan menjadi ibu semakin matang. Selain itu kondisi kejiwaan bisa mempengaruhi kandungan, oleh karena itu orang tua harus mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi proses kehamilan.

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan, yaitu:

a. Kematangan emosional

Kematangan emosional penting untuk WUS dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui. WUS yang tidak memiliki kematangan emosional dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatannya.

b. Kemampuan untuk beradaptasi

WUS harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, seperti perubahan peran, tanggung jawab, dan gaya hidup. WUS yang tidak mampu beradaptasi dengan baik dapat mengalami stres dan gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan.

c. Pola pikir

Pola pikir WUS juga dapat mempengaruhi status kesehatannya. WUS yang memiliki pola pikir positif, seperti percaya diri dan optimis, cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, WUS yang memiliki pola pikir negatif, seperti pesimis dan merasa tidak berharga, cenderung memiliki kesehatan yang lebih buruk.

d. Perilaku

Perilaku WUS juga dapat mempengaruhi status kesehatannya. WUS yang memiliki perilaku yang sehat, seperti mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok, cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, WUS yang memiliki perilaku yang tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan yang tidak sehat, kurang berolahraga, dan merokok, cenderung memiliki kesehatan yang lebih buruk.

3. Kesiapan Lingkungan, Sosial Budaya, dan Ekonomi

a. Kebiasaan adat istiadat

Ada beberapa kebiasaan adat istiadat yang merugikan kesehatan ibu hamil. Penyampaian mengenai pengaruh adat dapat melalui berbagai teknik,

misalnya melalui media massa, pendekatan tokoh masyarakat, dan penyuluhan yang menggunakan media efektif. Serangkaian diadakan upacara bagi ibu hamil untuk mencari keselamatan bagi diri wanita serta bayinya. Contoh: mitoni, procotan dan brokohan, sepasaran dan selapan.

b. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kehamilan. Ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memadai dapat membantu untuk memastikan kesehatan pra konsepsi. Fasilitas yang memadai meliputi rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan spesialistik dan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, imunisasi, dan perencanaan kehamilan sehat.

c. Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor sosial yang dapat mempengaruhi kehamilan. Tingkat ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi kesehatan calon ibu hamil dan bayi yang nanti dikandungnya. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : 1) Akses yang terbatas terhadap makanan bergizi dan seimbang serta pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. 2) Ketergantungan pada pekerjaan fisik yang berat sehingga dapat membahayakan kesehatan pra konsepsi. 3) Stress akibat kesulitan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental prakonsepsi.

G. Rangkuman Materi

Masa remaja merupakan periode penting yang menentukan kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Remaja putri, khususnya, memerlukan perhatian khusus karena status gizi dan kesehatannya berpengaruh langsung pada kehamilan serta tumbuh kembang anak di masa depan. Upaya pencegahan stunting dimulai sejak remaja melalui skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah (TTD), serta penerapan pola makan dengan gizi seimbang agar kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan fisik dan mental dapat terpenuhi.

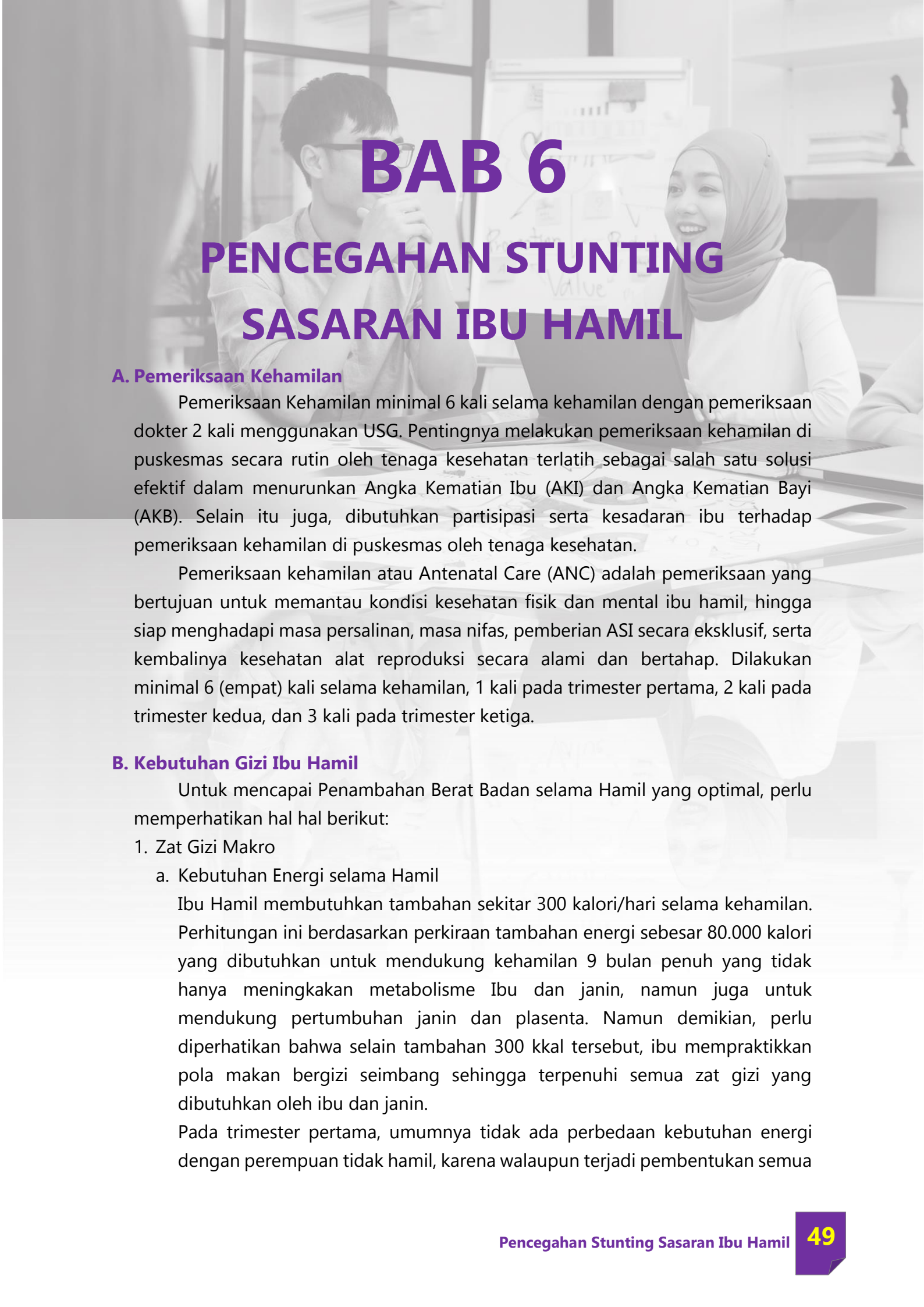
Selain itu, perilaku hidup sehat seperti menjaga kebersihan diri, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup perlu ditanamkan pada remaja putri. Edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, penundaan usia pernikahan, serta pemahaman tentang 1000 hari pertama kehidupan (HPK) menjadi kunci dalam mencegah stunting. Dengan langkah ini, remaja tidak hanya sehat saat ini, tetapi juga siap menjadi calon ibu yang mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas.

Pada tahap prakonsepsi dan pranikah, calon pengantin perempuan perlu dipersiapkan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Persiapan ini mencakup pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi, imunisasi, serta kesiapan

mental dan lingkungan keluarga. Dengan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai serta kesadaran masyarakat, risiko stunting dapat ditekan sejak dini. Dengan demikian, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara berkesinambungan mulai dari masa remaja, pranikah, hingga kehamilan, agar tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

H. Glosarium

Anemia	:	Kekurangan hemoglobin darah.
Hemoglobin (Hb)	:	Protein pengangkut oksigen.
TTD (Tablet Tambah Darah)	:	Suplemen zat besi.
Gizi Seimbang	:	Pola makan bergizi lengkap.
1000 HPK	:	Masa penting kehamilan–2 tahun.
Prakonsepsi	:	Masa sebelum hamil.
IMT	:	Ukuran berat/tinggi badan.
LiLA	:	Ukuran lingkaran lengan atas.
Vaksin TT	:	Vaksin cegah tetanus.
Growth Spurt	:	Pertumbuhan cepat remaja.
Pranikah	:	Masa sebelum menikah.

A background image showing a man and a woman in a professional setting. The man, wearing glasses, is looking at a laptop. The woman, wearing a hijab, is smiling and looking towards the man. They appear to be in a meeting or collaborative work environment.

BAB 6

PENCEGAHAN STUNTING

SASARAN IBU HAMIL

A. Pemeriksaan Kehamilan

Pemeriksaan Kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dengan pemeriksaan dokter 2 kali menggunakan USG. Pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas secara rutin oleh tenaga kesehatan terlatih sebagai salah satu solusi efektif dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu juga, dibutuhkan partisipasi serta kesadaran ibu terhadap pemeriksaan kehamilan di puskesmas oleh tenaga kesehatan.

Pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan fisik dan mental ibu hamil, hingga siap menghadapi masa persalinan, masa nifas, pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi secara alami dan bertahap. Dilakukan minimal 6 (empat) kali selama kehamilan, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga.

B. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Untuk mencapai Penambahan Berat Badan selama Hamil yang optimal, perlu memperhatikan hal hal berikut:

1. Zat Gizi Makro

a. Kebutuhan Energi selama Hamil

Ibu Hamil membutuhkan tambahan sekitar 300 kalori/hari selama kehamilan. Perhitungan ini berdasarkan perkiraan tambahan energi sebesar 80.000 kalori yang dibutuhkan untuk mendukung kehamilan 9 bulan penuh yang tidak hanya meningkatkan metabolisme Ibu dan janin, namun juga untuk mendukung pertumbuhan janin dan plasenta. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa selain tambahan 300 kkal tersebut, ibu mempraktikkan pola makan bergizi seimbang sehingga terpenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu dan janin.

Pada trimester pertama, umumnya tidak ada perbedaan kebutuhan energi dengan perempuan tidak hamil, karena walaupun terjadi pembentukan semua

cikal bakal organ tubuh pada trimester pertama, energi yang dibutuhkan sedikit. Namun pada trimester kedua dan ketiga, kebutuhan energi meningkat berturut-turut menjadi 340 kalori dan 452 kalori/hari. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya laju metabolisme basal Ibu hingga mencapai 60% dibandingkan sebelum hamil. Di samping itu, kebutuhan energi tersebut juga bervariasi pada setiap Ibu, bergantung pada usia, IMT, dan tingkat aktivitasnya.

b. Kebutuhan Protein selama Hamil

Asumsi protein yang dianjurkan untuk perempuan dewasa adalah 55-65 g/hari. Selama kehamilan, kebutuhan protein berturut-turut meningkat sebanyak 1 g, 10 g, dan 30 g/hari pada trimester I, II, dan III. Karbohidrat harus menopang 60 atau 65% energi harian dan ini termasuk sekitar 3-4 porsi makanan pokok setiap hari. Asupan lemak total harus terdiri dari 20-35% kalori harian, meningkat sebanyak sekitar 2 g/hari dibandingkan dengan perempuan yang tidak hamil. Konsumsi pangan sumber protein hewani selain untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial (protein penting yang tidak dibentuk oleh tubuh), juga untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Sebagai gambaran atas terpenuhinya kebutuhan zat gizi tersebut, kenaikan berat badan ibu yang optimal setiap trimesternya harus dicapai, dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 6.1
Pertambahan Berat Badan selama Kehamilan yang direkomendasikan sesuai IMT Sebelum Hamil

IMT sebelum hamil	Tambahan BB total	Pertambahan BB per minggu pada trimester 2 dan 3
Kurus (<18.5 kg/m ²)	12.5 – 18 kg	0.5 kg
Normal (18.5-24.9 kg/m ²)	11.5-16 kg	0.4 kg
Gemuk (25.0-29.9 kg/m ²)	7-11.5 kg	0.3 kg
Obesitas (>30.0 kg/m ²)	5-9 kg	0.2 kg

2. Zat Gizi Mikro

Secara umum, ibu hamil membutuhkan mineral dan vitamin yang sangat penting untuk mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan dan untuk pertumbuhan/ perkembangan janinnya. Mineral esensial tersebut adalah: besi, kalsium, tembaga, iodium, magnesium, selenium, dan zinc. Sedangkan vitamin, semua vitamin diperlukan, terutama adalah Asam Folat, sesuai dengan besarnya risiko bila kekurangan, seperti spina bifida. Kekurangan mineral dan vitamin juga

dapat berakibat gangguan pada fungsi imun, gangguan perkembangan otak dan sistem syaraf, anemia, preeklampsia, BBLR, dan prematuritas. Secara umum, ibu hamil membutuhkan tambahan vitamin A, berbagai vitamin B, dan vitamin C. Sedangkan kebutuhan mineral yang meningkat selama kehamilan adalah Ca, Besi, Iodium, seng, Selenium, Mangan, Chromium, dan Tembaga. Rekomendasi asupan zat gizi mikro untuk ibu hamil menurut usia kehamilan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 3.3

Tabel 6.2
Angka Kecukupan Vitamin yang Dianjurkan untuk Ibu Hamil

Kelompok Umur	Vit A (RE)	Vit D (mcg)	Vit E (mcg)	Vit K (mcg)	Vit B1 (mg)	Vit B2 (mg)	Vit B3 (mg)	Vit B5 (Pantotenat) (mg)	Vit B6 (mg)	Folat (mcg)	Vit B12 (mcg)	Biotin (mcg)	Kolin (mg)	Vit C (mg)
Hamil (+an)														
Trimester 1	+300	+0	+0	+0	+0.3	+0.3	+4	+1	+0.6	+200	+0.5	+0	+25	+10
Trimester 2	+300	+0	+0	+0	+0.3	+0.3	+4	+1	+0.6	+200	+0.5	+0	+25	+10
Trimester 3	+300	+0	+0	+0	+0.3	+0.3	+4	+1	+0.6	+200	+0.5	+0	+25	+10

Tabel 6.3
Angka Kecukupan Mineral yang Dianjurkan untuk Ibu Hamil

Kelompok Umur	Kalsium (mg)	Fosfor (mg)	Magnesium (mg)	Besi (mg)	Iodium (mcg)	Seng (mg)	Selenium (mcg)	Mangan (mg)	Fluor (mg)	Kromium (mcg)	Kalium (mg)	Natrium (mg)	Klor (mg)	Tembaga (mcg)
Hamil (+an)														
Trimester 1	+200	+0	+0	+0	+70	+2	+5	+0.2	+0	+5	+0	+0	+0	+100
Trimester 2	+200	+0	+0	+9	+70	+4	+5	+0.2	+0	+5	+0	+0	+0	+100
Trimester 3	+200	+0	+0	+9	+70	+4	+5	+0.2	+0	+5	+0	+0	+0	+100

Secara rinci, kebutuhan beberapa jenis zat gizi mikro Ibu Hamil dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Zat Besi

Zat besi merupakan mineral yang penting tidak hanya pada masa kehamilan, bahkan sejak remaja. Berdasarkan AKG 2019, kebutuhan zat besi bervariasi pada setiap kelompok umur perempuan. Namun, kebutuhan zat besi tertinggi ada pada kelompok usia produktif atau perempuan usia subur (13 – 49 tahun) yakni sebesar 15 – 18 mg/hari dan meningkat sebanyak 9 mg/hari untuk perempuan hamil pada trimester 2 dan 3. Untuk memenuhi kebutuhan zat besi, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan kaya zat besi termasuk daging merah, hati, ayam, ikan, dan sayur berdaun hijau tua serta buah berwarna oranye seperti pepaya.

b. Asam Folat

Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sel yang cepat, pembelahan sel, dan pembentukan sel-sel saraf dalam perkembangan janin dan plasenta. Kebutuhan folat meningkat selama kehamilan pertumbuhan janin. untuk mendukung Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2019, kebutuhan perempuan tidak hamil akan folat adalah sebesar 400 mcg/hari dan meningkat menjadi 600 mcg/hari selama kehamilan (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Sumber bahan makanan kaya folat adalah buah jeruk, sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, dan hati.

c. Vitamin A

Vitamin A sangat penting untuk pembelahan dan perkembangan sel, perkembangan tulang belakang, jantung, mata, dan telinga. Anak dari ibu yang mengalami kekurangan vitamin A, memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, yang mungkin terkait dengan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Meskipun sebagian besar zat gizi mikro memiliki ambang batas toleransi yang tinggi untuk dikonsumsi, vitamin A merupakan salah satu pengecualian. Konsumsi vitamin A (dalam bentuk retinol, bukan karoten seperti yang secara alami terkandung dalam wortel) yang berlebihan (>10.000 IU atau 3.000 RE/hari), misalnya dari suplemen, dapat memberikan efek teratogenik, seperti cacat jantung, langit-langit dan rongga mulut.

Berdasarkan AKG 2019, perempuan membutuhkan asupan Vitamin A sebesar 600 RE/hari dan bertambah menjadi 900 RE/hari selama hamil. Oleh karena efek sampingnya yang berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis tinggi saat hamil, maka sangat dianjurkan agar penambahan asupan vitamin A dianjurkan secara alami dari makanan. Secara alami, Vitamin A dapat dijumpai pada sayur dan buah berwarna hijau tua atau oranye, seperti wortel, ubi jalar, bayam, brokoli; serta dari sumber pangan hewani seperti hati ayam, telur, dan ikan. Di samping itu, asupan protein yang cukup juga dibutuhkan untuk mendukung proses pengangkutan/transportasi vitamin A dalam darah ke organ atau jaringan tubuh yang membutuhkan.

d. Kalsium

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak kandungannya didalam tubuh, 99% berada di dalam tulang, sisanya didalam darah dan cairan interstitial sel. Kalsium sangat penting untuk pertumbuhan/ perkembangan janin, oleh karenanya kebutuhan Kalsium ibu meningkat selama kehamilan. Sejak kehamilan usia 20 minggu, kandungan Kalsium di dalam sirkulasi darah janin lebih tinggi dibandingkan di dalam plasma ibu. Kekurangan Kalsium saat kehamilan dikaitkan dengan risiko berat badan lahir rendah (BBLR),

prematuritas dan kenaikan tekanan darah ibu hamil. WHO merekomendasikan suplementasi Kalsium selama hamil pada populasi yang konsumsi Kalsiumnya rendah, sebesar 1.5 g - 2 g per hari dibagi dalam 3 dosis (3 x 500 mg), yang dimulai pada kehamilan usia 20 minggu. Sumber utama Kalsium dalam makanan adalah susu, sereal dan sayur.

e. Probiotik dan Prebiotik

Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Salah satu mekanisme dari probiotik adalah mampu menekan atau menghambat pertumbuhan dari bakteri jahat dari dalam saluran pencernaan, khususnya usus besar, jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai.

Probiotik dapat ditambahkan pada produk pangan yang diproses dengan fermentasi seperti yoghurt dan dapat juga ditambahkan pada produk susu, dan produk lain dalam bentuk serbuk, cairan, maupun kapsul/tablet. Prebiotik adalah makanan yang tidak dapat tercerna oleh saluran pencernaan manusia namun bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan atau aktivitas bakteri baik/probiotik. Adapun prebiotik umumnya didapatkan dari gandum utuh, kedelai, pisang, bawang merah, bombay, bawang putih, dan madu. Probiotik dan prebiotik dinyatakan mampu mengurangi gejala berbagai penyakit seperti diare, infeksi usus, mencegah dan mengobati eksim, flu, perlemakan hati, dan menurunkan gejala kolik pada bayi (berkurangnya crying time). ASI juga diketahui mengandung oligosakarida yang memberikan efek seperti prebiotik yang mampu membantu tubuh bayi melawan bakteri (dengan memperkuat dinding usus dari serangan bakteri) dan menyeimbangkan komposisi microbiota pada usus bayi.

3. Contoh menu sehat untuk ibu hamil

Dianjurkan gunakan visualisasi isi piringku, agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai zat gizi tambahan zat gizi makro dan mikro melalui keragaman pangan yaitu: Isi separuh bagian piring makan anda dengan makanan pokok dan lauk pauk, lebih banyak makanan pokoknya; dan isi separuh piring lainnya dengan buah dan sayur, lebih banyak sayurnya. Untuk Ibu Hamil, dilengkapi dengan kudapan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi sebesar 300 kkal serta protein sebesar 10 g dan 30 g pada trimester 2 dan 3 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 6.4

Jumlah Porsi Makan dan Minum Menurut Kecukupan Energi untuk Ibu Hamil

Bahan Makanan	Ibu Tidak Hamil dan Tidak Menyusui (WUS)	Ibu Hamil Trimester 1	Ibu Hamil Trimester 2 & 3	Contoh
Nasi atau Makanan Pokok	5 porsi 	5 porsi 	6 porsi 	1 porsi = 100 g atau ¼ gelas nasi
Protein hewani seperti: ikan, telur, ayam, dan lainnya	3 porsi 	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 50 g atau 1 potong sedang ikan 1 porsi = 55 g atau 1 butir telur ayam
Protein nabati seperti: tahu, tempe, dan lainnya	3 porsi 	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 50 g atau 2 potong sedang tempe 1 porsi = 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur – sayuran	3 porsi 	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah – buah	5 porsi 	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 100 g atau 1 potong sedang pisang 1 porsi = 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak	5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	5 porsi Minyak atau lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan	1 porsi = 5 g atau 1 sendok teh, yang digunakan dalam pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis dan pengolahan lainnya yang menggunakan minyak
Gula	2 porsi 	2 porsi 	2 porsi 	1 porsi = 10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue manis, teh manis dan lain-lainnya Gula dapat digunakan untuk pengolahan makanan/minuman

Isi piringku tidak selalu harus menggambarkan keragaman dan proporsi di setiap kali makan, tetapi bisa juga menggambarkan keragaman dan proporsi kelompok makanan dalam sehari. Jadi, isi piringku dapat dipraktikkan untuk setiap kali makan, pagi, siang dan malam atau dapat merupakan keragaman dan proporsi makanan dalam sehari, yang merupakan kombinasi makan pagi, makan siang dan makan malam. Khusus untuk ibu hamil ditambah kudapan dengan nilai kalori 300 kkal yang dapat dijadikan satu kali atau dua kali kudapan seharinya dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 6.5
Penerapan ISI PIRINGKU dalam Sehari untuk Ibu Hamil

Waktu Makan	ISI PIRINGKU	Komposisi Makanan
Makan Pagi	 + 2 gelas Air Putih	1 porsi sayur dan ½ porsi protein hewani (tumis daun pepaya, kacang panjang dan ikan teri) + 1-2 porsi karbohidrat (nasi putih) + 1 porsi protein nabati (tempe goreng) + ½ porsi protein hewani (½ butir telur rebus) + 1 potong besar pepaya.
Kudapan Pagi	 + 2 gelas Air Putih	1-2 porsi protein nabati (kacang hijau) + 1 porsi karbohidrat (ubi merah) + 1-2 porsi lemak (santan)
Makan Siang	 + 2 gelas Air Putih	1-2 porsi sayur (bobot daun singkong) dan 1 porsi protein hewani (1 potong bebek goreng) disantap dengan 1 porsi karbohidrat (nasi putih), 1 porsi protein nabati (semur tahu), dan 1 buah jeruk
Makan Malam	 + 2 gelas Air Putih	1 porsi sayur + 1 porsi protein nabati (lodeh kacang panjang dan tempe) + 1 porsi protein hewani (1 potong ikan kembung goreng) + 1-2 porsi karbohidrat (nasi putih) + 1 potong besar buah naga

Tabel 6.6
Porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari

Bahan Makanan	12 minggu pertama	Keterangan per porsi
Nasi atau Makanan Pokok	5 porsi   	• 100 g atau 3/4 gelas nasi • 125 g atau 3 buah jagung sedang • 210 g atau 2 kentang sedang • 120 g atau 1/2 potong singkong • 70 g atau 3 iris roti putih • 200 g atau 2 gelas mie basah
Protein Hewani Ikan, Telur, Ayam dll.	4 porsi    	• 50 g atau 1 potong sedang ikan • 55 g atau 1 butir telur Ayam
Protein Nabati Tempe, Tahu, dll.	4 porsi    	• 50 g atau 1 potong sedang tempe • 100 g atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi    	100 g atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi    	• 100 g atau 1 potong sedang pisang • 100-190 g atau 1 potong besar pepaya
Minyak/Lemak	5 porsi     	5 g atau 1 sendok teh, bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya. Minyak/lemak termasuk santan yang digunakan dalam pengolahan, makanan digoreng, ditumis atau dimasak dengan santan.
Gula	2 porsi  	10 g atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis dan lain-lainnya
Batasi konsumsi garam paling banyak 1 sendok teh/hari dan minum air putih 8 - 12 gelas per hari.		

4. Konsumsi tablet tambah darah (TTD) Ibu Hamil

Pemberian TTD bagi ibu hamil diperlukan untuk memenuhi asupan zat besi guna mempersiapkan proses kehamilan dan persalinan yang sehat. Untuk mencegah anemia, diberikan minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan

Saat minum TTD, sarankan ibu untuk mengonsumsi makanan yang kaya protein dan mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi, serta menghindari minum teh atau kopi yang akan mengganggu penyerapan TTD. Untuk mengurangi mual, sarankan minum TTD saat malam hari sebelum tidur.

5. Pemberian makanan tambahan lokal bagi Ibu Hamil KEK

Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yaitu Ibu hamil yang mempunyai Indeks Massa Tubuh pra hamil atau pada trimester 1 (< 12 minggu) sebesar < 18,5 kg/m². Ibu Hamil Risiko (KEK) yaitu Ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm

Prinsip Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil, yaitu:

- PMT Ibu Hamil diberikan selama minimal 120 hari dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan penggunaan bahan lokal
- Berupa tambahan dan bukan pengganti makanan utama
- Pemberian MT di Posyandu, Fasyankes, Kelas Ibu Hamil atau melalui kunjungan rumah oleh kader/nakes/mitra Diberikan setiap hari dengan

komposisi sedikitnya 1 kali makanan lengkap dalam seminggu dan sisanya kudapan. Makanan lengkap diberikan sebagai sarana edukasi implementasi isi piringku.

- d. Pemberian MT disertai dengan edukasi, dapat berupa demo masak, penyuluhan dan konseling.

6. Pola hidup bersih dan sehat (PHBS)

Phbs adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Sebagai sebuah gerakan, phbs dilakukan di berbagai tempat aktivitas sehari-hari: di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum.

PHBS di rumah tangga, yaitu:

- a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan baik itu dokter, bidan ataupun paramedis memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril dan juga aman. Dapat mencegah infeksi dan bahaya yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan.

- b. Pemberian asi eksklusif.

Kesadaran mengenai pentingnya asi bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkat rumah tangga.

- c. Menimbang bayi dan balita secara berkala.

Dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Penimbangan secara teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk.

- d. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman.

- e. Menggunakan air bersih.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat.

f. Menggunakan jamban sehat.

Jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan.

g. Memberantas jentik nyamuk.

Nyamuk merupakan vektor (organisme yang tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebarkannya dengan membawa patogen/mikroorganisme penyebab penyakit dari satu inang ke yang lain) berbagai jenis penyakit. Memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit.

h. Konsumsi buah dan sayur.

Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat.

i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari.

Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga.

j. Tidak merokok di dalam rumah.

Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan.

C. Rangkuman Materi

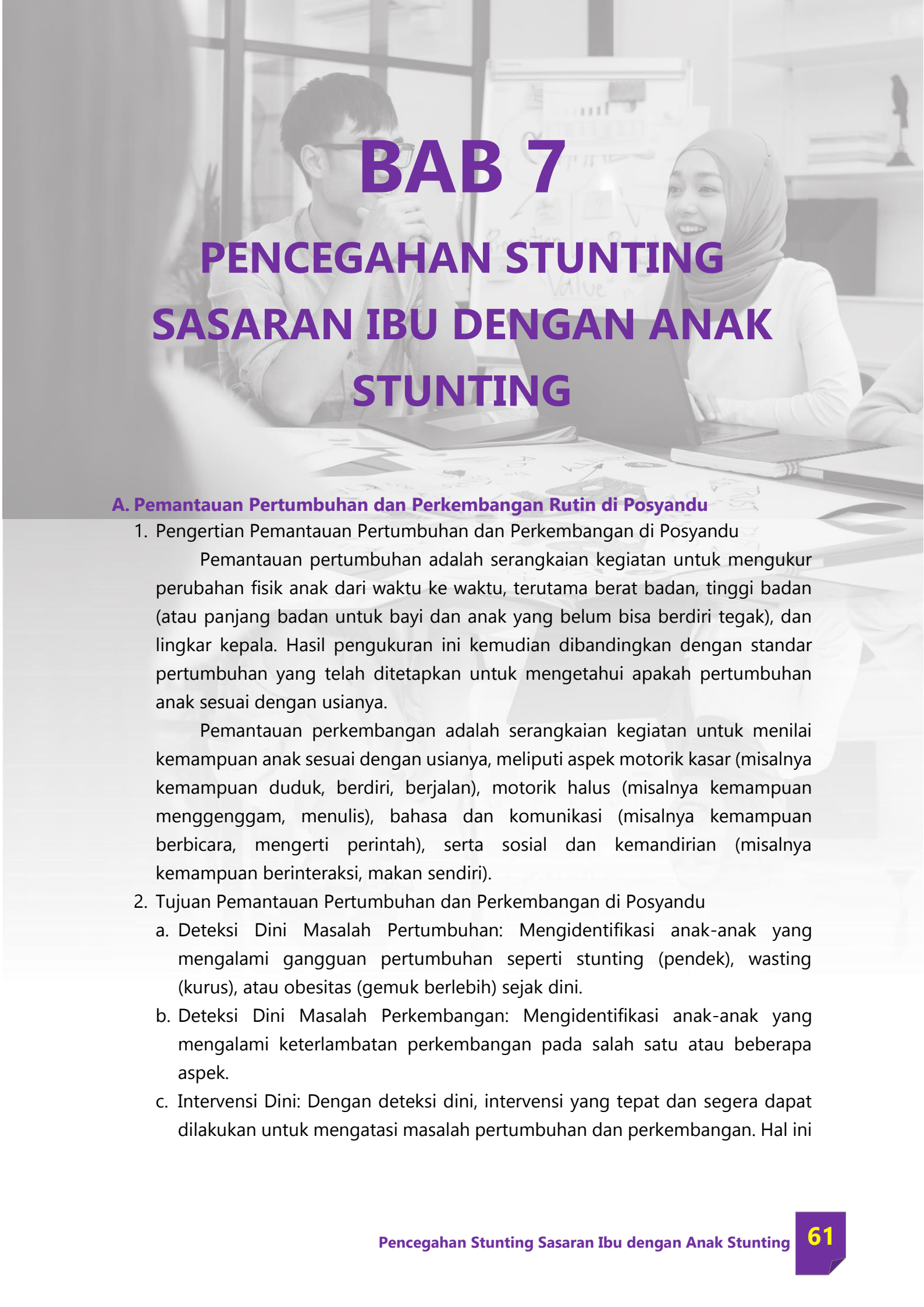
Ibu hamil memiliki peran penting dalam pencegahan stunting sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin (Antenatal Care/ANC). Pemeriksaan minimal enam kali selama masa kehamilan, termasuk pemeriksaan USG, sangat penting untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin serta mencegah risiko kematian ibu dan bayi. Dengan pemantauan yang baik, ibu hamil dapat lebih siap menghadapi persalinan, masa nifas, dan pemberian ASI eksklusif.

Selain pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi yang seimbang menjadi aspek utama. Ibu hamil membutuhkan tambahan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral, termasuk zat besi, asam folat, vitamin A, kalsium, serta dukungan probiotik dan prebiotik untuk menunjang kesehatan ibu dan perkembangan janin. Konsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan diperlukan untuk mencegah anemia. Sementara itu, ibu hamil dengan risiko kekurangan energi kronis (KEK) dianjurkan mendapatkan makanan tambahan bergizi lokal sebagai upaya meningkatkan status gizi dan kesehatan.

Penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) juga menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting. Upaya tersebut meliputi persalinan oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif, penimbangan bayi secara rutin, menjaga kebersihan dengan cuci tangan, penggunaan air dan jamban sehat, pemberantasan sarang nyamuk, konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, serta menghindari rokok di dalam rumah. Dengan kombinasi pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi, konsumsi suplemen, serta perilaku hidup sehat, ibu hamil dapat meminimalkan risiko stunting dan melahirkan generasi yang sehat serta berkualitas.

D. Glosarium

ANC (Antenatal Care)	: Pemeriksaan kehamilan rutin
USG	: Alat untuk melihat kondisi janin
TTD (Tablet Tambah Darah)	: Suplemen zat besi ibu hamil
KEK (Kurang Energi Kronis)	: Kondisi gizi ibu hamil kurang
IMT (Indeks Massa Tubuh)	: Ukuran berat badan ideal
Asam Folat	: Vitamin B untuk pembentukan sel janin
Kalsium	: Mineral penting untuk tulang ibu dan janin
Vitamin A	: Vitamin untuk perkembangan sel dan daya tahan
Probiotik	: Bakteri baik untuk pencernaan
Prebiotik	: Makanan untuk menumbuhkan bakteri baik
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	: Kebiasaan menjaga kesehatan dan kebersihan

A background image showing a man and a woman in a professional setting. The man, wearing glasses, is seated at a table with his hands clasped, looking towards the woman. The woman, wearing a hijab, is also seated at the table, looking at a laptop. They appear to be in a meeting or collaborative work environment. The title text is overlaid on this image in a large, bold, purple font.

BAB 7

PENCEGAHAN STUNTING

SASARAN IBU DENGAN ANAK STUNTING

A. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Rutin di Posyandu

1. Pengertian Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan di Posyandu

Pemantauan pertumbuhan adalah serangkaian kegiatan untuk mengukur perubahan fisik anak dari waktu ke waktu, terutama berat badan, tinggi badan (atau panjang badan untuk bayi dan anak yang belum bisa berdiri tegak), dan lingkaran kepala. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah pertumbuhan anak sesuai dengan usianya.

Pemantauan perkembangan adalah serangkaian kegiatan untuk menilai kemampuan anak sesuai dengan usianya, meliputi aspek motorik kasar (misalnya kemampuan duduk, berdiri, berjalan), motorik halus (misalnya kemampuan menggenggam, menulis), bahasa dan komunikasi (misalnya kemampuan berbicara, mengerti perintah), serta sosial dan kemandirian (misalnya kemampuan berinteraksi, makan sendiri).

2. Tujuan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan di Posyandu

- a. Deteksi Dini Masalah Pertumbuhan: Mengidentifikasi anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan seperti stunting (pendek), wasting (kurus), atau obesitas (gemuk berlebih) sejak dini.
- b. Deteksi Dini Masalah Perkembangan: Mengidentifikasi anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan pada salah satu atau beberapa aspek.
- c. Intervensi Dini: Dengan deteksi dini, intervensi yang tepat dan segera dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini

sangat penting karena intervensi dini memberikan peluang yang lebih besar untuk perbaikan.

- d. Memberikan Konseling dan Edukasi: Petugas Posyandu memberikan informasi dan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang, stimulasi perkembangan, dan praktik pengasuhan yang baik.
 - e. Rujukan: Jika ditemukan masalah pertumbuhan atau perkembangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap seperti Puskesmas atau dokter spesialis.
 - f. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin.
 - g. Mendapatkan Data Agregat: Data hasil pemantauan di Posyandu dapat digunakan untuk memantau status gizi dan perkembangan anak di tingkat komunitas atau wilayah.
3. Kegiatan Pemantauan di Posyandu
- a. Penimbangan Berat Badan: Anak ditimbang berat badannya menggunakan timbangan bayi atau timbangan injak. Hasilnya dicatat pada Kartu Menuju Sehat (KMS).
 - b. Pengukuran Tinggi Badan/Panjang Badan: Bayi dan anak yang belum bisa berdiri diukur panjang badannya menggunakan alat ukur panjang badan. Anak yang sudah bisa berdiri diukur tinggi badannya menggunakan alat ukur tinggi badan. Hasilnya juga dicatat pada KMS.
 - c. Pengukuran Lingkar Kepala: Terutama penting untuk bayi dan anak usia di bawah 2 tahun untuk mendeteksi adanya masalah pada perkembangan otak.
 - d. Pengisian KMS: Petugas Posyandu akan mencatat hasil pengukuran pada KMS. Orang tua akan melihat grafik pertumbuhan anak dan dapat membandingkannya dengan garis normal.
 - e. Penilaian Perkembangan: Petugas Posyandu akan melakukan skrining perkembangan menggunakan alat bantu sederhana seperti Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Denver Developmental Screening Test (DDST) yang disesuaikan dengan usia anak. Orang tua juga akan ditanya mengenai milestone perkembangan anak.
 - f. Konseling Gizi dan Kesehatan: Petugas memberikan nasihat mengenai pemberian makanan yang tepat sesuai usia anak, pentingnya ASI eksklusif, imunisasi, dan stimulasi perkembangan.
 - g. Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Di beberapa Posyandu, diberikan PMT untuk anak-anak yang terindikasi kurang gizi.
4. Manfaat Rutin ke Posyandu untuk Pemantauan Tumbuh Kembang

- a. Gratis: Pelayanan di Posyandu umumnya gratis atau sangat terjangkau.
- b. Akses Mudah: Posyandu biasanya berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat.
- c. Deteksi Dini: Memungkinkan masalah tumbuh kembang terdeteksi lebih awal.
- d. Mendapatkan Informasi yang Tepat: Orang tua mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya mengenai kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- e. Berinteraksi dengan Orang Tua Lain: Orang tua dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang tua lain.

B. ASI Eksklusif pada Bayi < 6 Bulan

1. Pengertian ASI eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan, tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat-obatan atau vitamin dan mineral yang diresepkan oleh dokter. Ini berarti bayi hanya menerima ASI dari payudara ibu atau ASI perah yang diberikan melalui sendok, cangkir, atau botol.

2. Manfaat ASI eksklusif

- a. Nutrisi Terbaik dan Lengkap: ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal selama 6 bulan pertama kehidupannya. Komposisi ASI dinamis dan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan bayi di setiap tahap perkembangannya. ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat dan mudah dicerna oleh bayi.
- b. Melindungi dari Penyakit (Antibodi): ASI kaya akan antibodi dan zat kekebalan tubuh yang melindungi bayi dari berbagai infeksi bakteri dan virus, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi telinga. Antibodi ini diturunkan dari ibu kepada bayi melalui ASI, terutama kolostrum (ASI yang keluar pertama kali).
- c. Mendukung Perkembangan Otak: ASI mengandung asam lemak esensial seperti DHA (Docosahexaenoic Acid) dan ARA (Arachidonic Acid) yang sangat penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik.
- d. Meningkatkan Ikatan Batin (Bonding): Proses menyusui menciptakan kontak fisik dan emosional yang erat antara ibu dan bayi. Hal ini memperkuat ikatan batin (bonding) yang penting untuk perkembangan psikologis dan emosional bayi.

- e. Manfaat Jangka Panjang: Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kronis di kemudian hari, seperti alergi, asma, obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung.
 - f. Mudah Dicerna: Kandungan dalam ASI sangat mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang masih belum sempurna. Hal ini mengurangi risiko masalah pencernaan seperti kolik dan sembelit.
 - g. Praktis dan Ekonomis: ASI selalu tersedia, tidak perlu disiapkan, dan diberikan pada suhu yang tepat. Selain itu, ASI gratis sehingga sangat ekonomis bagi keluarga.
 - h. Manfaat Bagi Ibu: Menyusui membantu rahim ibu kembali ke ukuran semula lebih cepat, mengurangi risiko perdarahan setelah melahirkan, dan dapat menunda kembalinya siklus menstruasi (sebagai kontrasepsi alami sementara). Menyusui juga dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara dan kanker ovarium pada ibu.
3. Cara memberikan ASI Eksklusif
- a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD): Letakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir (skin-to-skin contact) dan biarkan bayi mencari puting susu sendiri. IMD membantu merangsang produksi ASI dan memberikan kolostrum yang sangat berharga bagi bayi.
 - b. Pemberian ASI Sesuai Permintaan Bayi (On Demand): Susui bayi kapan pun ia menunjukkan tanda-tanda lapar, seperti mengecap-ngecap bibir, menggerakkan kepala mencari puting, atau memasukkan tangan ke mulut. Jangan terpaku pada jadwal tertentu.
 - c. Posisi dan Pelekatan yang Benar: Pastikan posisi dan pelekatan bayi saat menyusui benar agar bayi dapat menghisap ASI dengan efektif dan mencegah puting ibu lecet.
 - d. Tidak Memberikan Makanan atau Minuman Lain: Hindari memberikan makanan atau minuman lain selain ASI kepada bayi di bawah usia 6 bulan, termasuk air putih, teh, madu, atau susu formula (kecuali atas indikasi medis).
 - e. Dukungan Keluarga dan Lingkungan: Dukungan dari suami, keluarga, dan lingkungan sekitar sangat penting agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif dengan tenang dan lancar.
 - f. Konsultasi dengan Tenaga Kesehatan: Jika ibu mengalami kesulitan dalam menyusui, segera konsultasikan dengan dokter, bidan, atau konselor laktasi untuk mendapatkan bantuan dan solusi.
4. Pemberian MP-ASI kaya protein hewani untuk baduta

Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang kaya protein hewani sangat penting untuk tumbuh kembang optimal bayi berusia di bawah dua tahun (baduta). Protein hewani mengandung asam amino esensial yang lengkap dan mudah diserap oleh tubuh bayi, berperan krusial dalam pembentukan otot, tulang, otak, dan sistem kekebalan tubuh.

a. Manfaat pemberian Protein Hewani Penting dalam MP-ASI

- 1) Membangun dan Memperbaiki Jaringan Tubuh:* Protein adalah bahan penyusun utama sel-sel tubuh. Asupan protein yang cukup membantu dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh bayi yang sedang berkembang pesat.
- 2) Mendukung Perkembangan Otak:Asam amino seperti taurin dan DHA (yang banyak terdapat pada ikan) penting untuk perkembangan kognitif dan penglihatan bayi.
- 3) Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh:Protein berperan dalam pembentukan antibodi yang melindungi bayi dari infeksi.
- 4) Mencegah Stunting: Kekurangan protein kronis dapat menyebabkan stunting (tubuh pendek dan gagal tumbuh), yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan dan kecerdasan anak.
- 5) Sumber Zat Besi dan Zink:Protein hewani, terutama daging merah dan hati, merupakan sumber zat besi dan zink yang baik. Zat besi penting untuk mencegah anemia, sementara zink berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan.

b. Cara pemberian Protein Hewani

Protein hewani dapat mulai diperkenalkan sejak bayi berusia 6 bulan, bersamaan dengan dimulainya MP-ASI. Berikut adalah beberapa tips pemberian protein hewani:

- 1) Mulai dengan Tekstur Lembut: Awalnya, berikan protein hewani dengan tekstur yang sangat lembut dan halus, seperti daging ayam atau ikan yang dihaluskan, telur orak-arik yang lembut, atau hati ayam yang dihaluskan.
- 2) Perhatikan Porsi: Mulailah dengan porsi kecil, sekitar 1-2 sendok teh, dan secara bertahap tingkatkan sesuai dengan usia dan kemampuan makan bayi.
- 3) Variasi Sumber Protein: Berikan berbagai jenis protein hewani seperti daging merah (sapi, kambing), daging putih (ayam, ikan), telur, dan hati secara bergantian untuk memastikan asupan nutrisi yang beragam.
- 4) Kombinasikan dengan Makanan Lain: Sajikan protein hewani bersama dengan sumber karbohidrat (nasi, kentang, ubi), sayuran, dan buah-buahan untuk makanan yang seimbang.

- 5) Hindari Penambahan Garam dan Gula Berlebihan: Batasi penambahan garam dan gula pada MP-ASI bayi.
 - 6) Perhatikan Alergi: Perkenalkan setiap jenis protein hewani satu per satu dan amati reaksi alergi pada bayi. Jika ada riwayat alergi keluarga terhadap jenis protein tertentu, konsultasikan dengan dokter sebelum memberikannya.
- c. Contoh Resep MP-ASI Kaya Protein Hewani:
- Berikut adalah beberapa contoh resep MP-ASI sederhana yang kaya protein hewani untuk bayi berusia 6-9 bulan:
- 1) Puree Ayam dengan Wortel:
- Bahan:
- a) 50 gram daging ayam tanpa tulang, rebus hingga matang
 - b) 1 buah wortel ukuran kecil, rebus hingga empuk
 - c) Sedikit air matang atau air kaldu ayam
- Cara Membuat:
- a) Haluskan daging ayam dan wortel rebus menggunakan blender atau saringan kawat.
 - b) Tambahkan sedikit air matang atau air kaldu ayam jika puree terlalu kental.
 - c) Aduk rata dan sajikan dalam keadaan hangat.



Gambar 7.1

Pure Ayam dengan Wortel

- 2) Bubur Hati Ayam dengan Bayam:
- Bahan:
- a) 30 gram hati ayam, rebus hingga matang dan haluskan
 - b) Segenggam bayam, cuci bersih dan rebus sebentar, cincang halus
 - c) 2 sendok makan nasi tim
 - d) Air kaldu ayam secukupnya

Cara Membuat:

- a) Campurkan nasi tim, hati ayam yang sudah dihaluskan, dan bayam cincang dalam panci kecil.
- b) Tambahkan air kaldu ayam secukupnya hingga mencapai konsistensi bubur yang diinginkan.
- c) Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih dan matang.
- d) Sajikan dalam keadaan hangat.



Gambar 7.2
Bubur Hati Ayam dengan Bayam

3) Telur Orak-Arik Lembut dengan Brokoli:

Bahan:

- a) 1 butir telur ayam, kocok lepas
- b) Beberapa kuntum brokoli, rebus hingga empuk dan cincang halus
- c) Sedikit minyak zaitun atau unsalted butter

Cara Membuat:

- a) Panaskan sedikit minyak zaitun atau unsalted butter di teflon kecil.
- b) Tuang telur yang sudah dikocok. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga menjadi orak-arik yang lembut dan matang.
- c) Tambahkan cincangan brokoli, aduk sebentar.
- d) Sajikan dalam keadaan hangat.

Telur Orak-Arik Lembut dengan Brokoli



1 Soft ur soft friting poti tika denga texture is bestre mihaketali eggs rang sematictersan tiid soft tembuc. tangtunndure.



2 Prepe Orak-Arik Lembut Telur Orak to hefzomertat andironge Bleest. petet csc'lerenield buncnolead, tangtun frelounhio eapmatne. Roriton Telurong brik eonbete a bincetebu- Penatseatre Stina soobinsl. adge deng akengan brokoli.



4 Prepiar Orak-Arik Lembut Blein-Brokoli Denicit thanyg'ennomd and moatetex. Hius fehaterrek kaghtan Rorotad.



INGREDIENTS

RECIPS

- 1 00 d eggs
- 1 50 g Brokoli
- 250 g mags
- 200 g mags
- 1 0d eggs
- 35d mags
- 150 Yabrekoli
- 1 Rilitan
- 2.51ag 8 steand
- 6u. Riggs
- 1.50 g peane-
- 1.50k fireet
- 2.50 6z fries

Cretting

Stir frioli

Tirtur Mobir

Rager Eogel

SHOPPING LIST



Gambar 7.3
Telut Orak Arik Lembut dengan Brokoli



Gambar 7.4
Makanan Pendamping ASI

C. Hal-hal penting yang harus diperhatikan pada anak stunting

Berikut adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan pada anak stunting:

1. Pemantauan Pertumbuhan Rutin dan Akurat
2. Intervensi Gizi yang Intensif dan Komprehensif
 - a. Pemberian Makanan Padat Gizi: Fokus pada makanan tinggi protein hewani (ikan, telur, ayam, daging), lemak sehat (minyak, santan, alpukat), dan karbohidrat kompleks.
 - b. Porsi Kecil tapi Sering: Anak stunting mungkin memiliki nafsu makan yang rendah. Berikan makan utama 3 kali dan selingan (snack) 2-3 kali sehari dengan porsi kecil namun padat kalori dan nutrisi.
 - c. Fortifikasi dan Suplementasi: Pastikan anak mendapatkan asupan mikronutrien penting seperti zat besi, seng (zinc), vitamin A, dan vitamin D. Jika perlu, konsultasikan dengan dokter untuk pemberian suplemen.
 - d. Cairan yang Cukup: Pastikan anak terhidrasi dengan baik.
3. Kebersihan Lingkungan dan Sanitasi

Lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan infeksi berulang yang mengganggu penyerapan nutrisi.

- a. Akses Air Bersih: Pastikan anak dan keluarga memiliki akses terhadap air bersih yang aman untuk minum dan mencuci.

- b. Jamban Sehat: Gunakan jamban yang bersih dan layak. Hindari buang air besar sembarangan.
 - c. Cuci Tangan Pakai Sabun: Ajarkan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Ini sangat efektif mencegah penyebaran kuman.
4. Pencegahan dan Penanganan Penyakit Infeksi
- Penyakit seperti diare atau ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dapat memperburuk kondisi gizi anak.
- a. Imunisasi Lengkap: Pastikan anak mendapatkan semua imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.
 - b. Segera Obati Penyakit: Jika anak sakit (demam, diare, batuk pilek), segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk penanganan yang tepat.
 - c. Hindari Paparan Asap Rokok: Asap rokok dapat meningkatkan risiko ISPA pada anak.
5. Pola Asuh dan Stimulasi yang Tepat
- Stunting seringkali tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga perkembangan kognitif.
- a. Pemberian Makan yang Responsif: Pahami dan respons sinyal lapar dan kenyang anak. Jangan memaksa anak makan. Buat suasana makan yang menyenangkan.
 - b. Stimulasi Dini: Berikan stimulasi yang sesuai usia untuk mendukung perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Ajak anak bermain, berbicara, bernyanyi, dan membaca buku bersama.
 - c. Kasih Sayang: Lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian dapat meningkatkan nafsu makan dan perkembangan emosional anak.
6. Edukasi Orang Tua dan Keluarga
- a. Pengetahuan Gizi: Orang tua harus memahami pentingnya gizi seimbang, cara mengolah makanan yang benar, dan jenis makanan yang cocok untuk anak.
 - b. Kesehatan Reproduksi: Bagi pasangan usia subur, penting untuk merencanakan kehamilan dan memastikan gizi ibu hamil tercukupi sejak sebelum kehamilan untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan.
7. Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Pada Bayi
- Kebutuhan bayi mencerminkan tingkat pertumbuhan, energi yang dikeluarkan dalam aktivitas, kebutuhan metabolisme basal, dan interaksi gizi yang dikonsumsi. Kebutuhan tersebut umumnya lebih tinggi setiap satu kilogram berat badan pada bayi dibandingkan dengan usia lain dalam satu siklus kehidupan. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan percepatan

pembelahan sel dan sintesis DNA pada proses pertumbuhan terutama dari sumber energi dan protein.

Beberapa hari pertama kehidupan, bayi kemungkinan akan kehilangan sekitar 7% dari berat badannya dan biasanya kembali bertambah pada hari ketujuh hingga kesepuluh. Penurunan berat badan lebih dari 10% pada bayi baru lahir menunjukkan perlunya penilaian lebih lanjut mengenai kecukupan pemberian makan berdasarkan kebutuhan bayi. Jumlah berat yang diperoleh bayi selama tahun kedua mendekati berat lahir. Total lemak tubuh meningkat dengan cepat selama 9 bulan pertama, setelah itu tingkat penambahan lemak menurun sepanjang sisa masa kanak-kanak. Kapasitas perut bayi meningkat dari kisaran 10 hingga 20 mL saat lahir menjadi 200 mL pada usia 1 tahun, hal ini memungkinkan bayi untuk mengonsumsi lebih banyak makanan pada waktu tertentu dengan frekuensi yang lebih jarang seiring bertambahnya usia.

Pada usia balita, anak-anak membutuhkan dukungan nutrisi yang lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan otak mereka. Masa balita adalah masa kritis, maka kebutuhan nutrisi bagi balita haruslah seimbang, baik dalam jumlah (porsi) maupun kandungan gizi. Pencapaian gizi seimbang pada balita akan membuat anak tumbuh cerdas, sehat serta tidak mudah terserang penyakit.

Gizi seimbang didapat dari asupan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi sesuai usia dan kegiatan sehingga tercapai berat badan normal. Gizi pada balita harus seimbang, mencakup zat gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Balita membutuhkan asupan karbohidrat sebesar 75-90%, protein sebesar 10-20% dan lemak sebesar 15-20%. Tepatnya, balita membutuhkan zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur sebagai perpaduan zat gizi seimbang sebagai berikut:

a. Karbohidrat

Karbohidrat adalah senyawa gabungan dari molekul karbon, hidrogen dan oksigen. Karbohidrat bermanfaat untuk menghasilkan energi untuk pertumbuhan otak dan tubuh. Disamping membantu metabolisme lemak dan protein. Ada dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Contoh karbohidrat sederhana adalah glukosa, fruktosa dan galaktosa, yang terkandung dalam buah-buahan, susu dan madu. Karbohidrat kompleks adalah glikogen, selulosa, serat dan pati (starch), terdapat pada nasi, mie, bihun, roti, jagung, kentang dan umbi-umbian. Sumber energi yang berasal dari karbohidrat seperti ini adalah sumber energi yang paling mudah ditemui karena merupakan makanan pokok.

Glikogen merupakan simpanan energi cadangan dalam tubuh yang tersimpan dalam hati dan otot. Bila jumlahnya berlebih maka karbohidrat yang tidak tersimpan akan diubah menjadi lemak. Kondisi ini menyebabkan timbulnya obesitas. Sebaliknya bila asupan energi dan protein kurang akan menyebabkan kekurangan energi dan protein (KEP). Untuk itu penghitungan kebutuhan energi pada balita haruslah tepat. Sebagai patokan, untuk setiap 1 gram karbohidrat, energi yang dihasilkan adalah sebesar 4 kalori.

b. Protein

Protein adalah salah satu sumber energi dan sumber zat pembangun, Protein akan diubah menjadi sumber energi bila energi yang berasal dari karbohidrat dan lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Akibatnya, protein tidak dapat menjalankan fungsi sebagai zat pembangun, sehingga tumbuh kembang balita terhambat.

Sumber protein dapat ditemui pada hewan (hewani) dan tanaman (nabati). Jenis pangan yang mengandung protein hewani berasal dari ayam, daging, ikan, telur dan susu. Sedangkan sumber pangan protein nabati adalah tahu dan tempe, biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein hewani adalah sumber protein berkualitas tinggi. Setiap 1 gram protein menghasilkan 4 kalori.

c. Lemak

Lemak adalah sumber energi yang lain. Sumber lemak diperoleh dari lemak hewani dan nabati. Sumber lemak hewani dapat ditemui pada daging, minyak ikan, kuning telur, dan mentega. Sedangkan lemak nabati didapatkan dari lemak tumbuhan, contohnya margarin, minyak sawit, kacang tanah, santan dan kelapa.

Sebagai sumber energi, 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori, dibandingkan dengan karbohidrat dan protein yang per satu gramnya hanya menghasilkan 4 kalori. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K, melindungi anggota tubuh, menghangatkan tubuh. Asam lemak esensial berfungsi bagi pertumbuhan dan perkembangan otak.

d. Zat Pembangun

Selain sebagai sumber energi, protein juga berfungsi sebagai zat pembangun. Sebagai zat pembangun, protein berperan dalam pembentukan jaringan, tulang, otot dan sel-sel tubuh. Protein juga berfungsi untuk membangun sel-sel tubuh yang rusak, pembentuk antibodi (kekebalan tubuh), serta pembentukan sel darah merah, enzim dan hormon. Pada anak-anak, protein berfungsi sebagai sintesis protein otot dan pemeliharaan jaringan.

e. Zat Pengatur

Vitamin, mineral dan air merupakan zat pengatur yang sangat diperlukan untuk proses metabolisme tubuh. Ketiga zat pengatur ini membantu proses tumbuh kembang pada balita. Vitamin dan mineral berfungsi menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit. Walau vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun zat ini tetap dibutuhkan oleh tubuh. Kekurangan zat ini bisa menyebabkan balita mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah terserang penyakit.

f. Vitamin

Vitamin merupakan senyawa organik yang tidak diproduksi oleh tubuh, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tubuh, harus dikonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Vitamin dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu

1) Vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, K) Vitamin A, D, E, dan K merupakan vitamin yang menggunakan lemak sebagai pelarut

a) Vitamin A

Vitamin A berperan dalam penglihatan, pertumbuhan, menjaga kesehatan tubuh dari infeksi, reproduksi, serta pembentukan dan pertumbuhan sistem saraf. Vitamin A adalah salah satu vitamin yang mengandung antioksidan selain vitamin C dan E. Sumber Vitamin A dapat diperoleh dari sumber hewani, seperti hati sapi, hati ayam, telur daging dan susu, serta juga dapat ditemukan pada sumber nabati berupa sayuran berwarna hijau tua, seperti bayam, kangkung atau pada wortel, jeruk, ubi rambat. Angka kecukupan vitamin A yang dianjurkan pada balita adalah 1.500 IU untuk usia 1-3 tahun (batita), dan 1.800 IU vitamin A untuk usia 4-6 tahun (prasekolah).

Tabel 7.1
Bahan makanan sumber Vit A Per 100 gram

Bahan Makanan Nabati	SI	Bahan Makanan Hewani	SI
Biji jagung muda, kuning	117	Daging ayam	810
Biji jagung baru panen, kuning	440	Hati sapi	43.900
Biji jagung panen lama, kuning	510	Ginjal sapi	1150
Ubi rambat, merah	7.700	Telur itik	1.230
Lamtoro, biji muda	423	Ikan segar	150
Kacang ijo kering	157	Daging sapi	30
Wortel	12.000	Teri	210
Bayam	6.000	Telur ayam	900
Daun melinjo	10.000	Bandeng	150
Daun singkong	11.000	Kerang	300
Genjer	3800	Keju	750
Kangkung	6300	Kuning telur	2000
Belimbing	170	Udang	60
Avokad	180	Ikan mas	150
Mangga	6350	Mentega	3300
Apel	90	Minyak sawit	60000
Jambu biji	25	Susu sapi	130

b) Vitamin D

Vitamin D atau kalsiferol adalah vitamin yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, meningkatkan penyerapan dan proses metabolisme fosfor dan kalsium dalam tubuh, serta produksi hormon. Sumber vitamin D yang termurah dan termudah yang dapat dibuat oleh tubuh adalah melalui paparan sinar matahari yang menghasilkan sinar ultraviolet dan mengenai kulit tubuh. Sumber lainnya dapat ditemukan pada keju, telur, susu, tahu, tempe dan minyak ikan.

Keuntungan balita yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia, mudah terpapar sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Jadi biarkanlah anak-anak bermain di halaman rumah terutama di pagi hari. Di Indonesia defisiensi vitamin D jarang terjadi. Kekurangan vitamin D menyebabkan timbulnya penyakit riketsia atau kaki bengkak membentuk huruf O, kelainan tulang kaki berbentuk X, gigi dan tulang mudah keropos, dan pertumbuhan balita menjadi terhambat.

c) Vitamin E

Vitamin E merupakan antioksidan karena mampu menyehatkan kulit, melindungi tubuh anak dari pengaruh radikal bebas, melancarkan sirkulasi darah, membantu membuat sel darah merah, mempercepat proses penyembuhan luka, membantu perkembangan otak dan proses reproduksi. Angka kecukupan vitamin E untuk usia 1-3 tahun (batita) adalah 6 mg perhari. Sumber vitamin E dapat ditemukan pada minyak

sayur, kecambah, gandum, kiwi dan margarin. Kekurangan vitamin E akan menyebabkan gangguan penyerapan, dan mengganggu perkembangan otak dan sel darah merah.

d) Vitamin K

Vitamin K adalah vitamin yang digunakan untuk proses pembekuan darah saat terjadi luka sehingga sering disebut vitamin antiperdarahan. Vitamin K juga diperlukan dalam proses pembentukan tulang dan sintesa beberapa protein.

Sumber vitamin K dapat ditemukan pada sayuran berwarna hijau berdaun banyak, kacang polong, kol, kentang, kacang-kacangan, tomat. Dari sumber hewani bisa ditemukan pada hati, daging, telur dan susu. Selain itu, vitamin K juga dihasilkan oleh bakteri di saluran pencernaan. Sehingga kebutuhan vitamin K pada balita dapat terpenuhi secara baik. Angka kecukupan vitamin K pada balita adalah 15 mg/hari dan balita 20 mg/hari. Sedangkan bayi mendapat asupan vitamin K dari ASI atau makanan yang mengandung vitamin K karena saluran pencernaan bayi belum bisa menghasilkan vitamin K. Kebutuhan vitamin K pada anak akan meningkat bila terjadi perdarahan, luka atau demam berdarah.

2) Vitamin yang Larut dalam Air

Vitamin yang termasuk dalam kelompok ini adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Jenis vitamin dalam kelompok ini menggunakan air sebagai pelarut.

a) Vitamin B kompleks

Vitamin B kompleks merupakan gabungan dari beberapa jenis vitamin B, yang terdiri dari vitamin B1 (Thiamin), vitamin B2 (Riboflavin), vitamin B3 (Niasin), Vitamin B5 (Asam Pantotenat), vitamin B6 (Piridoksin), vitamin B9 (asam folat), vitamin B12 (Siano-kobalamin), dan Biotin. Vitamin B kompleks sangat berperan dalam proses metabolisme energi (zat tenaga) sehingga membantu pertumbuhan, kesehatan saraf, dan mencegah terjadinya infeksi terutama pada balita dengan daya tahan tubuh yang masih lemah.

b) Vitamin C (Asam askorbat)

Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan dan antibiotik. Selain itu, vitamin C membantu proses penyembuhan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, gigi dan gusi, serta membantu pembentukan tulang. Kekurangan vitamin C akan mengakibatkan kulit tidak sehat, sariawan di mulut atau perut, perdarahan di gusi, anemia, tubuh cepat merasa lelah, serta timbul penyakit skorbut.

Tabel 7.2
Sumber vitamin larut dalam air

Jenis Vitamin	Sumber
Vitamin B1	Makanan laut, hati, daging, padi-padian, roti, sereal, susu, biji-bijian, telur, tempe.
Vitamin B2	Keju, telur, kacang almond, susu, yoghurt, brokoli.
Vitamin B3	Daging, unggas, ikan, telur, padi-padian, sereal, susu, roti, kacang-kacangan, kacang polong, tomat, jamur, bayam.
Vitamin B5	Padi-padian, roti, susu, sereal.
Vitamin B6	Olahan gandum, sayuran hijau berdaun banyak, daging, ikan, kentang, biji-bijian, susu.
Vitamin B9	Brokoli, bayam, olahan gandum, susu, telur, kacang-kacangan, tempe, kubis, daging.
Vitamin B12	Daging, hati, salmon, tuna, unggas, kerang, kepiting, telur, susu, tempe.
Biotin	Hati, telur, susu, ginjal.
Vitamin C	Bayam, mangga, papaya, nenas, rambutan, jeruk, daun papaya, daun singkong, brokoli, sawi.

c) Mineral

Mineral merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Walau jumlahnya kecil, mineral harus tetap ada karena dibutuhkan dalam proses metabolisme. Selain itu mineral juga membantu proses pertumbuhan dan perkembangan balita, menjaga kesehatan balita dan membentuk tulang yang kuat.

Mineral memiliki cakupan yang luas. Namun beberapa diantaranya merupakan zat mineral penting bagi pertumbuhan dan perkembangan balita, yaitu kalsium (Ca), zat besi (Fe), Yodium (I), Magnesium (Mg), Selenium (Se), Potasium (P), Fosfor (F), Fluor (FI), dan Seng (Zn).

Tabel 7.3
Sumber mineral

Jenis Mineral	Sumber
Kalsium	Keju, susu, bayam, yoghurt, ikan, kacang-kacangan, jeruk, apel, roti, brokoli
Zat besi	Daging, hati, telur, kerang, ikan, unggas, teri kering, udang, tempe, bayam, kangkung, sereal
Yodium	Ikan, udang, kerang, ganggang laut kering, sarden, telur, bayam, buncis kering
Magnesium	Sayurang berwarna hijau tua, advokad, pisang, daging, susu, biji-bijian, kacang polong
Selenium	Hati, daging, unggas, telur, biji-bijian, ikan, susu
Potasium	Jeruk, pisang, susu, buncis, kentang, semangka, tomat, sayuran
Fosfor	Daging, unggas, telur, ikan, susu dan produk olahan, biji-bijian, kacang-kacangan
Fluor	Tempe, telur, air, dan sumber makanan hewani
Seng	Ikan, telur, unggas, daging, susu dan produk olahan, biji-bijian, kacang-kacangan

d) Air

Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, yakni 50-75% dari berat total tubuh. Air adalah kebutuhan vital bagi manusia. Bagi balita, air memegang peranan penting bagi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan karena itu asupan air harus dijaga. Salah satunya demi mencegah dehidrasi, yaitu suatu kondisi yang membahayakan kesehatan dan jiwa bayi dan balita. Apalagi bayi dan balita sangat mudah kehilangan cairan melalui ginjal (buang air kecil yang sering) dan kulit (berkeringat banyak). Selain itu, bayi dan balita yang kekebalan tubuh masih labil, mudah terserang penyakit seperti diare dan muntah-muntah yang mengakibatkan kehilangan cairan dalam jumlah banyak. Karena itu, penting untuk memperhatikan kebutuhan air pada bayi dan balita.

e) Serat (dietary fiber)

Serat bukan merupakan zat gizi, namun serat dibutuhkan oleh balita untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Serat membantu kesehatan pencernaan dengan mencegah terjadinya konstipasi (sembelit) yang sering terjadi pada balita. Pemenuhan serat dapat diperoleh dari sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian.

Tabel 7.4
Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan untuk balita/hari

Kelompok umur	0-6 bulan	7-11 bulan	1-3 tahun	4-6 tahun
Tinggi badan (cm)	60	71	90	110
Berat badan (kg)	6,0	8,5	12,0	17,0
Energi (kkal)	550	650	1000	1550
Protein (g)	10	16	25	39
Vitamin A (RE)	375	400	400	450
Vitamin D (mcg)	5	5	5	5
Vitamin E (mg)	4	5	6	7
Vitamin K (mcg)	5	10	15	20
Thiamin (mg)	0,3	0,4	0,5	0,6
Riboflavin (mg)	0,3	0,4	0,5	0,6
Niacin (mg)	2	4	6	8
Asam Folat (mcg)	65	80	150	200
Piridoksin (mg)	0,1	0,3	0,5	0,6
Vitamin B 12 (mcg)	0,4	0,5	0,9	1,2
Vitamin C (mg)	40	40	40	45
Kalsium (mg)	200	400	500	500
Fosfor (mg)	100	225	400	400
Magnesium (mg)	25	55	60	80
Besi (mg)	0,5	7	8	9
Yodium (mcg)	90	90	90	120
Seng (mg)	1,3	7,5	8,2	9,7
Selenium (mcg)	5	10	17	20
Mangan (mg)	0,003	0,6	1,2	1,5
Fluor (mg)	0,01	0,4	0,6	0,8

D. Rangkuman Materi

Pencegahan stunting pada anak yang sudah terindikasi stunting memerlukan pendekatan menyeluruh, dimulai dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin di Posyandu. Melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, serta penilaian perkembangan anak, dapat dilakukan deteksi dini dan intervensi segera apabila ditemukan masalah. Posyandu juga menjadi tempat penting untuk konseling gizi, pemberian makanan tambahan, serta edukasi kepada orang tua mengenai praktik pengasuhan yang sehat dan bergizi.

Selain pemantauan, pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan merupakan langkah utama untuk memastikan bayi mendapat nutrisi lengkap dan perlindungan kekebalan tubuh. Setelah usia 6 bulan, bayi memerlukan makanan pendamping ASI (MP-ASI) kaya protein hewani, seperti daging, ikan, telur, dan hati, untuk mendukung pertumbuhan otot, tulang, otak, dan sistem kekebalan tubuh. Pemberian MP-ASI harus dilakukan dengan cara yang tepat, mulai dari tekstur lembut, porsi kecil namun sering, hingga variasi sumber protein untuk mencukupi kebutuhan gizi.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan bagi anak stunting adalah pola asuh, kebersihan lingkungan, serta pencegahan penyakit infeksi. Anak stunting

memerlukan asupan makanan padat gizi, suplementasi mikronutrien, serta lingkungan yang bersih dengan akses air sehat dan sanitasi yang baik. Orang tua juga harus memahami pentingnya stimulasi perkembangan anak, kasih sayang, serta edukasi gizi untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Dengan kombinasi pemantauan, pemenuhan gizi, pola hidup sehat, dan dukungan keluarga, anak dengan stunting masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki kondisi dan tumbuh lebih sehat.

E. Glosarium

KMS (Kartu Menuju Sehat)	: Kartu pemantau pertumbuhan anak.
ASI Eksklusif	: ASI saja sampai usia 6 bulan.
MP-ASI	: Makanan pendamping ASI setelah 6 bulan.
Protein Hewani	: Gizi dari daging, ikan, telur, hati.
KPSP/DDST	: Alat skrining perkembangan anak.
Imunisasi	: Pemberian vaksin untuk cegah penyakit.
Fortifikas	: Penambahan zat gizi pada makanan.
PHBS	: Perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB 8

IMPLEMENTASI KOTA SOLOK DALAM PENANGANAN STUNTING

Pemerintah Kota Solok telah menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan stunting melalui berbagai program dan inovasi yang terintegrasi. Upaya ini melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan partisipasi aktif masyarakat. Berikut adalah beberapa implementasi Kota Solok dalam penanganan stunting:

A. Pembentukan dan Penguatan Tim

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS): TPPS di tingkat kota hingga desa/kelurahan aktif melakukan pemetaan, inovasi, dan aksi pencegahan stunting. Wali Kota Solok menargetkan angka stunting di bawah 5% melalui kerja kolaboratif ini.
2. Tim Pendamping Keluarga (TPK): TPK desa/kelurahan ditingkatkan perannya dalam pendampingan keluarga, khususnya pada calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita.

B. Program Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT):
 - a. Permata Kuning (Pemberian Makanan Tambahan Anak untuk Kurangi Stunting): Program pemberian PMT bagi anak-anak untuk mengatasi stunting.
 - b. Anting Permata Bumil (Atasi Stunting dengan Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil KEK): Fokus pada ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) untuk mencegah stunting sejak dini.
 - c. Bantuan Bahan Pangan: Dinas Pangan Kota Solok memberikan bantuan bahan pangan kepada keluarga dengan balita stunting, terutama di daerah rawan pangan, untuk memastikan kecukupan gizi.
2. Program Genteng (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting): Inisiatif ini melibatkan masyarakat sebagai orang tua asuh untuk membantu memenuhi

kebutuhan gizi anak-anak berisiko stunting melalui pemberian makanan bergizi. Ketua TP-PKK Kota Solok bahkan menjadi orang tua asuh bagi baduta berisiko stunting.

C. Inovasi dan Edukasi

1. PUTRI TAMIA (Remaja Putri Tanpa Anemia): Program untuk remaja putri guna mencegah anemia, yang merupakan salah satu faktor risiko stunting di kemudian hari.
2. Wali Bumil Cantik (Kawal dan Lindungi Ibu Hamil Guna Cegah Stunting Secara Spesifik): Program pendampingan dan perlindungan khusus bagi ibu hamil.
3. Kartu Pelangi: Media konseling yang berisi pesan-pesan gizi sesuai tumbuh kembang balita.
4. Rujak Stunting (Rujukan Terintegrasi untuk Anak Stunting): Sistem rujukan terintegrasi bagi anak stunting.
5. Kids and Mom Care: Pelayanan terpadu ibu dan anak dengan prinsip parenting.
6. Kamping Beken (Kader Pendamping Bayi Kecil Kembali Normal): Program untuk melatih kader pendamping agar bayi kecil dapat kembali normal.
7. Baralek Cetar (Bangun Keluarga Intelekt, Cerdas, dan Pintar): Program untuk membangun keluarga yang lebih sadar gizi dan pola asuh yang baik.
8. PSC 119 Smash Care's (Publik Safety Center 119, Solok Serambi Madinah Sehat Cara Revolusi Sehat): Inovasi di bidang pelayanan kesehatan.
9. Sosialisasi dan Penyuluhan: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara aktif melakukan sosialisasi tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemantauan tumbuh kembang anak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pola asuh.

D. Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor

1. Audit Kasus Stunting: Dilaksanakan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting dan mencegah kasus serupa.
2. Peningkatan Koordinasi Antar-OPD: Rapat dan pertemuan rutin diadakan untuk membahas solusi dan mengoptimalkan kolaborasi antar dinas terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Perumahan, dll.).
3. Dukungan Kebijakan Daerah: Adanya penetapan lokus stunting dan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai bentuk kebijakan pemerintah daerah.

E. Rangkuman Materi

Pemerintah Kota Solok menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penanganan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting

(TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini berperan aktif dalam pemetaan, pendampingan, serta edukasi bagi calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita. Target utama yang ingin dicapai adalah menurunkan angka stunting hingga di bawah 5% melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Program intervensi gizi spesifik dan sensitif juga dilaksanakan, seperti Permata Kuning untuk pemberian makanan tambahan anak, Anting Permata Bumil bagi ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronis (KEK), serta program Genteng yang melibatkan masyarakat sebagai orang tua asuh bagi anak berisiko stunting. Selain itu, bantuan bahan pangan juga disalurkan untuk keluarga dengan balita stunting di daerah rawan pangan, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi.

Sejumlah inovasi kreatif turut dikembangkan, seperti PUTRI TAMIA untuk pencegahan anemia pada remaja putri, Wali Bumil Cantik untuk perlindungan ibu hamil, Kartu Pelangi sebagai media konseling gizi, serta Rujak Stunting sebagai sistem rujukan terintegrasi. Program lain seperti Kids and Mom Care, Kemping Beken, Baralek Cetar, dan PSC 119 Smash Care's memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pemerintah juga mendorong koordinasi lintas sektor melalui audit kasus stunting, peningkatan kerja sama antar-OPD, serta kebijakan seperti penetapan lokus stunting dan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Semua langkah ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di Kota Solok dilakukan secara terintegrasi, inovatif, dan partisipatif.

F. Glosarium

TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)	:	Tim khusus percepatan pencegahan stunting
TPK (Tim Pendamping Keluarga)	:	Pendamping calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan balita
Permata Kuning	:	Program makanan tambahan anak cegah stunting
Anting Permata Bumil	:	Makanan tambahan untuk ibu hamil KEK
Genteng	:	Gerakan orang tua asuh cegah stunting
PUTRI TAMIA	:	Program remaja putri tanpa anemia
Wali Bumil Cantik	:	Pendampingan dan perlindungan ibu hamil
Kartu Pelangi	:	Media konseling gizi balita
Rujak Stunting	:	Sistem rujukan terintegrasi anak stunting
BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting)	:	Program adopsi gizi anak stunting oleh tokoh/pejabat

DAFTAR PUSTAKA

- Adminstr. 2024, 18 Mei. Skrining Pemeriksaan Hemoglobin (Hb) Sebagai bentuk Deteksi Dini Anemia Pada Remaja. Puskesmas Rejosari. <https://bit.ly/44x0IS9>
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. MODUL Pegangan bagi Fasilitator Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Membantu Remaja Merancang Masa Depan. Jakarta Timur. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Kemenkes. 12 Agustus 2018. Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan di Fasilitas Kesehatan atau Puskesmas. Ayo Sehat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://bit.ly/4eFinp7>
- Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden. 2025, 28 Mei. Prevalensi Stunting Indonesia Turun ke 19,8%. Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden. <https://bit.ly/4kcFyb7>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Pedoman Gizi Seimbang Ibu Hamil dan Ibu Menyusui. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Germas
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Buku Resep Makanan Lokal Bayi, Balita dan Ibu Hamil. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Buku Saku: Pencehan dan Penanggulangan Stunting Bagi Kader. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Germas
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Pedoman: Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Bagi Binas Kesehatan Dan Puskesmas. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Germas
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Buku Saku Kader Kesehatan Pemberian Makan Tambahan (PMT) Penyuluhan Balita 6-59 bulan. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Germas
- Laila, Rahmatul 6 April 2024. Dinkes Solok Lakukan Berbagai Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Antara <https://bit.ly/44yErxV>
- Matahari, Ratu Dan Suryani, Dyah. 2022. Peran Remaja Dalam Pencegahan Stunting. Yogyakarta. Banguntapan.
- Rahayu, Atikah Dkk. 2018. Buku Referensi Study Guide–Stunting Dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. CV Mine. Yogyakarta
- Samsudin Dkk. 2023. Stunting. Eureka Media Aksara. Bojongsari

- Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting). Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- TVRI Sumatra Barat. 29 Maret 2024. Angka Prevalensi Stunting di Sumbar Turun Jadi 23,6 Persen. TVRI Sumatra Barat. <https://bit.ly/4lsqis0>
- Wahyuni, Tavip Atti ,Yudiernawati dan Suryani, Pudji. 2025. Pemberdayaan Remaja Melalui Peer Educator Berbasis Literasi Digital Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Remaja. Jakarta. Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang
- World Health Organization. 2018. Reducing Stunting In Children: Equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Geneva

PROFIL PENULIS



Tintin Sumarni S.Kp, M.Kep., dilahirkan pada tanggal 01 Maret 1967 di Agam Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Menamatkan Pendidikan D3 di Akademi Keperawatan Padang tahun 1989. S1 di program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2000. S2 di Universitas Andalas jurusan Manajemen keperawatan tamat pada tahun 2014. Penulis memulai karir bekerja di di Dinas kesehatan tahun 1991 sampai tahun 1993. Guru Sekolah perawat Kesehatan (SPK) DepKes Solok dan Dosen di Akademi Keperawatan Solok dari tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011. Tahun 2012 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Padang Program studi D3 keperawatan Solok. Penulis juga aktif menjadi peneliti baik sebagai peneliti utama maupun anggota peneliti. Riwayat Organisasi yang pernah penulis ikuti dibidang pendidikan adalah menjadi Sekretaris Program studi D3 Keperawatan Solok tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. tim Auditor Mutu Internal (AMI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Organisasi publik yang pernah penulis ikuti adalah sebagai Wakil Bidang Diklat Persatuan Perawat Nasional Kota Solok tahun 2015-2020 dan tahun 2022-2027.



Dr. Aini Yusra Sp.Kep.M.B., lahir di Padang Panjang Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 1974. Masuk dalam dunia keperawatan dengan memulai pendidikan di Akademi Keperawatan Padang tamat tahun 1995 dan melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan di Universitas Andalas (UNAND) tamat pada tahun 2002. Selanjutnya menempuh pendidikan S2 Keperawatan Spesialis Medikal Bedah di Universitas Indonesia tamat tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan S3 Keperawatan tahun 2023 di Universitas Indonesia. Karir dimulai dengan bekerja sebagai guru di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Tahun 2011 sampai sekarang sebagai dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Padang Program Studi D3 Keperawatan Solok. Penulis memiliki beberapa penelitian nasional dan internasional baik sebagai peneliti utama dan sebagai anggota peneliti. Riwayat Organisasi yang pernah diikuti di bidang pendidikan adalah menjadi kordinator penelitian dan pengabmas di tingkat Prodi serta sebagai reviewer jurnal di tingkat Poltekkes. Organisasi publik yang pernah penulis ikuti adalah sebagai Ketua DPK Pendidikan PPNI Prodi D3 Keperawatan Solok tahun 2014 sampai tahun 2018 dan sebagai anggota di bidang penelitian sampai sekarang.

PROFIL PENULIS



R. Firwandri Marza, SKM, M.Kes., lahir pada 4 Juni 1965 di Desa Pasar Kuok, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. menamatkan pendidikan di Akademi Penilik Kesehatan (APK) Padang pada tahun 1988, kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tahun 1995 hingga memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2001, menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan di Universitas Indonesia di Depok Jawa Barat. Dalam Pengabdianya Selama 23 Tahun di Pemerintah Kota Solok (Tahun 1989 – 2013) pernah ditempatkan di Dinas Kesehatan Kota Solok, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Solok, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Solok. Awal tahun 2014 pindah tugas ke Poltekkes Kemenkes Padang dan di Amanahkan sebagai Dosen di Prodi Sarjana Kesehatan Kesehatan lingkungan sampai saat ini, aktif di organisasi profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan pernah dipercaya sebagai Ketua HAKLI Daerah Sumatera Barat tahun 2017-2022. Di bidang akademik, pernah sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang.



Abd Gafar, S.Kep, MPH., dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1964 di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Menamatkan Pendidikan D3 di Akademi Keperawatan Pajajaran Bandung tahun 1996. S1 di program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas tahun 2000. S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan peminatan Perilaku dan promosi Kesehatan (Promkes) tamat pada tahun 2012. Penulis memulai karir sebagai seorang perawat pelaksana di Rumah sakit Umum Muara Labuh sejak tahun 1986 sampai tahun 1996. Guru Sekolah perawat Kesehatan (SPK) DepKes Solok dan Dosen di Akademi Keperawatan Solok dari tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011. Tahun 2012 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Padang Program studi D3 keperawatan Solok. Penulis juga aktif menjadi peneliti baik sebagai peneliti utama maupun anggota peneliti. Riwayat Organisasi yang pernah penulis ikuti dibidang pendidikan adalah menjadi ketua Program studi D3 Keperawatan Solok tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sebagai Gugus Kendali Mutu (GKM), tim Auditor Mutu Internal (AMI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Organisasi publik yang pernah penulis ikuti adalah sebagai Anggota dewan pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Kota Solok tahun 2015-2020 dan tahun 2022-2027. Sebagai wakil ketua III Forum Kota Sehat Kota Solok 2014. Sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

PROFIL PENULIS



Ns. Deharnita, S.ST.M.Kes Anak kedua dari 4 bersaudara, Lahir di Kota Solok Sumbar, tanggal 5 Desember 1969, pendidikan keperawatan dimulai dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) tamat tahun 1988, kemudian melajut pendidikan ke PAM (Pendidikan Ahli Madya Keperawatan) Pajajaran Bandung tamat tahun 1995, Pada Tahun 1999 menamatkan pendidikan Diploma IV di Universitas Sumatera Utara, dan tahun 2022 menamatkan pendidikan S2 di FKM UI, setelah itu menambah pendidikan SI Keperawatan di STIKES Indonesia tamat tahun 2012. Penulis saat ini mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Tahun 2018-2022 di percaya sebagai ketua Program Studi DIII Keperawatan Solok Poltekkes Kemenkes Padang.

PROFIL PENULIS



Dr. Gusnedi Adiwarmanto, STP., MPH. merupakan dosen pada Jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Padang. Beliau lahir di Batusangkar pada tanggal 30 Mei 1971.

Perjalanan pendidikan beliau dimulai dari Akademi Gizi yang diselesaikan pada tahun 1993. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan sarjana di bidang Teknologi Pangan dan Gizi di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan meraih gelar S1 pada tahun 2000. Beliau kemudian memperoleh gelar Master of Public Health (MPH) dalam bidang Community Nutrition dari The University of Queensland, Australia, pada tahun 2005 melalui

Australian Development Scholarship (ADS) Award.

Komitmen beliau terhadap pengembangan manajemen pendidikan tinggi membawanya meraih beasiswa Netherlands Foundation Partnership (NFP) pada tahun 2010, untuk mengikuti pelatihan Leadership and Management in Higher Educational Institutions di Belanda. Pada tahun 2020, beliau berhasil menuntaskan pendidikan doktoralnya dalam bidang Ilmu Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bekerja sama dengan SEAMEO RECFON.

Dalam perjalanan karier akademiknya, Dr. Gusnedi pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Padang (2006–2010), Ketua Program Studi S1 Gizi Universitas Perintis (2012–2013), serta Kepala Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Padang (2014–2017). Saat ini, beliau dipercaya sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik Poltekkes Kemenkes Padang periode 2022–2026.

Selain kiprah akademiknya, Dr. Gusnedi juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Sumatera Barat, serta aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sebagai tenaga ahli dalam penyusunan program intervensi gizi masyarakat.

Dengan pengalaman akademik, kepemimpinan, dan pengabdian yang luas, beliau terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu gizi, pendidikan tinggi kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

Sinopsis

Buku "Pemberdayaan Masyarakat Mencegah Stunting" disusun untuk memberikan pemahaman mendalam. Tentang dampak stunting dibahas secara rinci dalam dua kategori besar, yakni dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, anak mengalami gangguan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan motorik, serta kerentanan terhadap penyakit infeksi. Sedangkan dampak jangka panjang mencakup rendahnya prestasi akademik, penurunan produktivitas kerja, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa.

Sebagai upaya pencegahan, buku ini menekankan pentingnya intervensi gizi spesifik pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Intervensi ini meliputi pemberian tablet tambah darah, pemantauan kehamilan secara teratur, pemberian ASI eksklusif, serta pemberian makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko stunting dapat ditekan sejak dini.

Selain intervensi gizi, buku ini juga menguraikan pentingnya intervensi sensitif yang mencakup perbaikan sanitasi, akses air bersih, peningkatan pola asuh anak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan multisektoral ini menegaskan bahwa stunting tidak dapat diatasi hanya melalui sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan pendidikan, sosial, dan pembangunan desa.

Peran kader kesehatan, khususnya kader Posyandu, mendapat perhatian khusus dalam buku ini. Kader menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, mulai dari penyuluhan, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga deteksi dini masalah gizi. Kehadiran kader dinilai sangat strategis dalam mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka stunting.

Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan berbagai program nasional penurunan stunting. Program-program tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan pemanfaatan dana desa. Seluruh program ini diarahkan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, dan sarana sanitasi yang memadai.

Buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga menghadirkan contoh kasus nyata di lapangan. Dengan demikian, pembaca dapat melihat bagaimana faktor-faktor penyebab stunting bekerja secara kompleks, serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Studi kasus ini juga memberi gambaran nyata tentang tantangan dan peluang dalam upaya pencegahan stunting di tingkat masyarakat.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas kepada mahasiswa, praktisi kesehatan, kader, dan masyarakat umum tentang pentingnya pencegahan stunting. Melalui sinergi semua pihak, mulai dari keluarga hingga pemerintah, prevalensi stunting dapat terus ditekan. Harapannya, lahirlah generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Buku "Pemberdayaan Masyarakat Mencegah Stunting" disusun untuk memberikan pemahaman mendalam. Tentang dampak stunting dibahas secara rinci dalam dua kategori besar, yakni dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, anak mengalami gangguan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan motorik, serta kerentanan terhadap penyakit infeksi. Sedangkan dampak jangka panjang mencakup rendahnya prestasi akademik, penurunan produktivitas kerja, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa.

Sebagai upaya pencegahan, buku ini menekankan pentingnya intervensi gizi spesifik pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Intervensi ini meliputi pemberian tablet tambah darah, pemantauan kehamilan secara teratur, pemberian ASI eksklusif, serta pemberian makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko stunting dapat ditekan sejak dini.

Selain intervensi gizi, buku ini juga menguraikan pentingnya intervensi sensitif yang mencakup perbaikan sanitasi, akses air bersih, peningkatan pola asuh anak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan multisektoral ini menegaskan bahwa stunting tidak dapat diatasi hanya melalui sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan pendidikan, sosial, dan pembangunan desa.

Peran kader kesehatan, khususnya kader Posyandu, mendapat perhatian khusus dalam buku ini.

Kader menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, mulai dari penyuluhan, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga deteksi dini masalah gizi. Kehadiran kader dinilai sangat strategis dalam mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka stunting.

Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan berbagai program nasional penurunan stunting. Program-program tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan pemanfaatan dana desa. Seluruh program ini diarahkan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, dan sarana sanitasi yang memadai.

Buku ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga menghadirkan contoh kasus nyata di lapangan. Dengan demikian, pembaca dapat melihat bagaimana faktor-faktor penyebab stunting bekerja secara kompleks, serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Studi kasus ini juga memberi gambaran nyata tentang tantangan dan peluang dalam upaya pencegahan stunting di tingkat masyarakat.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas kepada mahasiswa, praktisi kesehatan, kader, dan masyarakat umum tentang pentingnya pencegahan stunting. Melalui sinergi semua pihak, mulai dari keluarga hingga pemerintah, prevalensi stunting dapat terus ditekan. Harapannya, lahirlah generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

